

障害者教育総論 資料

小野島 昂洋

2025-04-03

Table of contents

第 1 章	はじめに	7
1.1	この資料について	7
1.2	コアカリキュラムとの対応	7
1.3	作成者およびライセンス	10
第 2 章	障害の捉え方	11
2.1	障害モデル	11
2.1.1	障害の医学モデルと社会モデルとは	11
2.2	ICIDH と ICF	12
2.2.1	ICIDH	12
2.2.2	ICF	14
2.3	障害者権利条約と合理的配慮	16
2.3.1	障害者権利条約の特徴	16
2.3.2	合理的配慮	18
2.4	補足	20
2.4.1	社会モデルと ICF の関係について (★)	20
2.4.2	理解を深めるための資料等 (★)	20
第 3 章	障害者の権利と当事者運動	21
3.1	ノーマライゼーション	21
3.1.1	バンク・ミケルセン	21
3.1.2	ニィリエ	22
3.1.3	ヴォルヘンスベルガー	23
3.2	自立生活運動	24
3.2.1	運動の起こりとその発展	24
3.2.2	自立生活運動における「自立」とは	25
3.3	青い芝の会とその運動	26
3.3.1	会の起こりと神奈川県連合会	26
3.3.2	障害児殺害事件への減刑嘆願への抗議活動	26
3.3.3	川崎バス闘争	27

3.4	補足 (★)	30
3.4.1	理解を深めるための資料等	30
第4章	日本における特別支援教育の歴史と制度	31
4.1	戦前の障害児教育	31
4.1.1	盲教育および聾唖教育	31
4.1.2	知的障害教育	32
4.1.3	肢体不自由児と病弱児	34
4.1.4	戦時下の教育	34
4.2	特殊教育	34
4.2.1	盲学校・聾学校教育の義務化と養護学校の整備の遅れ	35
4.2.2	通級による指導の制度化	35
4.3	特別支援教育	36
4.3.1	場による支援からニーズに応じた支援へ	36
4.3.2	小・中学校における特別支援教育の推進	37
4.3.3	特別支援学校のセンター的機能	38
4.4	特別支援学校の学習指導要領	39
4.4.1	自立活動とは	39
4.4.2	準ずる教育課程と知的障害及び重複障害のための教育課程	41
4.4.3	重複障害者等に関する教育課程の取扱い	42
4.5	補足	42
4.5.1	自立活動について参考資料 (★)	42
4.5.2	特別支援教育への転換期の重要文書 (★)	42
第5章	インクルーシブ教育と近年の動向	45
5.1	インクルーシブ教育とは	45
5.1.1	サランカ声明	45
5.1.2	インクルージョンのためのガイドライン	46
5.1.3	障害者の権利に関する条約との関連	48
5.2	近年の動向	50
5.2.1	特別支援教育を受ける児童生徒数の増加	50
5.2.2	障害者権利条約の対日審査	53
5.3	補足	56
5.3.1	ウェブ上で見ることができる映像等 (★)	56
第6章	関係機関との連携	57
6.1	個別の教育支援計画と他 (多) 職種連携	57
6.2	医療との連携	58
6.2.1	医療機関との連携	58
6.2.2	医療的ケアとは	59

6.2.3	特別支援学校の教員による医療的ケア	59
6.3	福祉との連携	60
6.3.1	放課後等デイサービス	60
第7章	障害者と成人期	63
7.1	特別支援学校卒業後の進路	63
7.1.1	高等教育機関への進学	63
7.1.2	企業への就職	64
7.1.3	福祉サービスの利用	64
7.2	成人期の生活とライフスキル	65
7.2.1	ライフスキルとは	65
7.2.2	特別支援学校におけるキャリア教育	67
第8章	保護者やきょうだいへの支援	69
8.1	保護者との連携	69
8.1.1	保護者との連携の必要性	69
8.1.2	支援対象としての保護者	70
8.1.3	「障害受容」という言葉について	72
8.2	きょうだいの支援	73
8.2.1	きょうだいをめぐる諸問題	73
8.2.2	きょうだい児への支援	73
8.3	補足	73
8.3.1	保護者の障害の受け止め方のモデル (★)	73
8.3.2	特別支援学校における連携の実際 (★)	74
第9章	障害者と決定	75
9.1	障害者の意思決定	75
9.1.1	法律行為と法律能力	75
9.1.2	障害者権利条約における法的能力	76
9.1.3	代行決定から支援を受けた自己決定へ	77
9.1.4	意思決定とコミュニケーションの支援	77
参考文献		81

第1章

はじめに

1.1 この資料について

この資料は愛知学院大学心理学部で開講している「障害者教育総論」という授業の補足資料です。授業では十分扱うことができなかった資料や学習のためのリソースを掲載しています。

なお、書いた目的や時期が異なる資料を集めた関係で所々つながりがおかしいですが、その内なおします。また工事中の箇所を多々含み、内容が頻繁に変わります。

節や項の最後のに★のマークがついているものは、細かい話だったり、発展的な話だったり、私が学んだ際の記録のために残したものであったりが、含まれますので読み飛ばしてもらっても構いません。

1.2 コアカリキュラムとの対応

「障害者教育総論」の授業は、特別支援学校教諭免許状取得のための「特別支援教育に関する科目」の第1欄「特別支援教育の基礎理論に関する科目」に対応する科目です。文部科学省は2022（令和4）年に、特別支援教育を担う教員が共通的に修得すべき資質・能力を示した「特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム」を策定しています^{*1}。特別支援教育の基礎理論に関する科目については以下のように示されています。

- 特別支援教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想
 - － 全体目標: 特別支援教育の理念とは何か、また、障害のある幼児、児童又は生徒の学校教育に関する歴史や思想において、特別支援教育の基本的な考え方がどのように現れてきたかについて学ぶとともに、これまでの特別支援教育及び特別支援学校の営みがどのように捉えられ、変遷してきたのかを理解する。

^{*1} [文部科学省 特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム](#)

1. 特別支援教育の理念
 - － 一般目標：特別支援教育の理念と特別支援学校に関する制度の相互の関係を理解する。
 - － 到達目標：
 1. 特別支援教育制度の成立と障害者の権利に関する条約に基づくインクルーシブ教育システムの理念を踏まえた特別支援教育への展開を理解している。
 2. 特別支援教育制度における特別支援学校が有する機能・役割を理解している。
2. 特別支援教育の歴史
 - － 一般目標：障害のある幼児、児童又は生徒の教育に関する歴史、特殊教育の果たしてきた役割や障害者施策を巡る動向の変化を踏まえつつ、現代に至るまでの特別支援教育の基本的な考え方及び特別支援学校の変遷を理解する。
 - － 到達目標：
 1. 障害のある幼児、児童又は生徒の教育に関する歴史、特殊教育の果たしてきた役割や障害者施策を巡る動向の変化を踏まえつつ、特別支援教育制度の成立と展開を理解している。
 2. 現代社会における特別支援学校における教育課題を歴史や障害者施策の視点から理解している。
3. 特別支援教育の思想
 - － 一般目標：特別支援教育の思想と特別支援教育の理念や実際の特別支援学校の教育との関わりを理解する。
 - － 到達目標：
 1. 障害のある幼児、児童又は生徒に関わる教育の思想を理解している。
 2. 特別支援学校や学習に関わる教育の思想を理解している。
- 特別支援教育に関する社会的、制度的又は経営的事項
 - － 全体目標：現代の特別支援学校の教育に関する社会的、制度的又は経営的事項のいずれかについて、基礎的な知識を身に付けるとともに、それらに関連する課題を理解する。
 - * (1-1) 特別支援教育に関する社会的事項
 - ・ 一般目標：社会の状況を理解し、その変化が特別支援学校の教育にもたらす影響とそこから生じる課題、並びにそれに対応するための教育政策の動向を理解する。
 - ・ 到達目標：
 1. 特別支援学校を巡る近年の様々な状況の変化及び子供の生活の変化を踏まえた指導上の課題を理解している。
 2. 近年の特別支援教育政策の動向を理解している。
 - * (1-2) 特別支援教育に関する制度的事項
 - ・ 一般目標：特別支援学校の公教育制度を構成している教育関係法規を

理解するとともに、そこに関連する特別支援学校教育要領・学習指導要領が有する役割・機能・意義を理解する。

・ 到達目標：

1. 特別支援学校の目的及び教育目標と国が定めた教育課程の基準との相互関係を理解している。
2. 特別支援学校教育要領・学習指導要領の性格及びそこに規定する自立活動や知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の教科、重複障害者等に関する教育課程の取扱いの基礎的な考え方を理解している。

＊（1-3）特別支援教育に関する経営的事項

・ 一般目標：特別支援学校や教育行政機関の目的とその実現について、経営の観点から理解する。

・ 到達目標：

1. 特別支援学校の目的や教育目標を実現するための学校経営の望むべき姿を理解している。
2. 幼児、児童又は生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等を踏まえた学級経営の基本的な考え方を理解している。
3. 教職員や学校外の関係者・関係機関との連携・協働の在り方や重要性を理解している

コアカリキュラムに示された内容と、この資料の各ページとの対応を表 1.1 を示しました。

表 1.1: この資料の各ページとコアカリキュラムの対応表

この資料の該当箇所	理念	歴史	思想	社会的 事項	制度的 事項	経営的 事項
2 障害の捉え方	○					
3 障害者の権利と当事者運動			○			
4 日本における特別支援教育の 歴史と制度	○	○			○	
5 インクルーシブ教育と国際的 な動向	○	○		○		
6 関係機関との連携						○
7 障害者と成人期				○		○
8 親やきょうだいへの支援						○
9 障害者と自己決定			○			

1.3 作成者およびライセンス

この資料の作成者は愛知学院大学心理学部の小野島昂洋です。資料に含まれる誤り等を見つけた方は [HP](#) のプロフィールページにあるメールアドレスからお知らせいただけると助かります。

この資料の内、私が作成した文章や画像については[クリエイティブ・コモンズ・ライセンス（表示-非営利 4.0 国際）](#)で公開します。

第2章

障害の捉え方

2.1 障害モデル

障害をどのようなものとして捉えるかによって、障害者への教育や支援のあり方は異なってきます。障害の捉え方は大きく分けると**医学モデル**と**社会モデル**の2つがあるとされています。

2.1.1 障害の医学モデルと社会モデルとは

障害とは従来は個人が持っているものという考え方でした。そこでは、障害は病気・外傷などから直接的に生じるものとして捉えられており、障害によって生じる問題は個人に原因があるとされます。また、障害から生じる問題の解決のためには医療などの専門職による援助を必要とするものとされます。こうした障害の捉え方を**医学モデル**と呼びます。

これに対して、障害はさまざまな社会的障壁によって作られるとする捉え方が1980年代のイギリスで登場しました。イギリスの障害学の研究者であるオリバー（Oliver）は、障害によって生じる問題は、障害のある人のニーズに応えるための適切なサービスを提供できなかった社会の側に原因があると考え、**社会モデル**を提唱しました。社会モデルでは、障害とは社会の中で生じるものなので、社会的な障壁を取り除くことで障害による不便を乗り越えようとしています。

これらの違いをより具体的に考えてみましょう。表 2.1 には障害によって生じている問題の状況と、医学モデルと社会モデルにおけるそれぞれの問題解決の方向性の違いを示しています。

表 2.1: 医学モデルと社会モデルの障害の捉え方と対応の比較

状況	医学モデル	社会モデル
Aさんは、足が動かず車椅子を利用中です。階段が登れないので、上の階へと移動できません。	足の機能を回復するための機能回復訓練を行って登れるようにする。	エレベータやスロープを設置して、車椅子のままでも上の階へと移動できるようにする。
Bさんは、視力には問題はないものの学習障害があり文字が読めません。そのため、教科書が読めず授業に参加することができません。	文字が読めるようになるための専門的な訓練をして、読字能力を鍛えて教科書を読めるようにする。	デジタル教科書と音声読み上げ機能のあるパソコンを使って内容を理解し、授業に参加できるようにする。

近年ではこうした2つの捉え方を対立させるのではなく統合して捉えようとしており、それを統合モデルと呼ぶこともあります（これについては、第2.2節や第2.4.1項も参照してください）。

2.2 ICIDH と ICF

前節の障害モデルはイギリスの障害学分野で発展した考え方でした。それらとは別の障害を捉える枠組みとして、世界保健機構（WHO）が発表した**国際障害分類**（International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, **ICIDH**）とその発展である**国際生活機能分類**（International Classification of Functioning, Disability and Health, **ICF**）はとても有名なものです。以下では上田（2005）の pp.7-28 を参考にして、これらについて解説します。

2.2.1 ICIDH

2.2.1.1 ICIDH の考え方

WHO は 1980 年に発表したものが ICIDH です。ICIDH における障害の捉え方を示したものが図 2.1 です。

図 2.1 では、病気やけがなどからなる「疾患・変調」から右の「機能・形態障害」に矢印が行き、さらなる「能力障害」や「社会的不利」に矢印がつながっています。ICIDH では、「機能・形態障害」「能力障害」「社会的不利」の3つからなる全体を障害だと考えます。「障害には3つの異なるレベルがある」という考えを打ち出したのが ICIDH において画期的だとされた点です。以下では、障害の3つのレベルのそれぞれについて確認します。

「機能・形態障害」とは、これ自体が1つの言葉というよりは、機能障害と形態障害の2

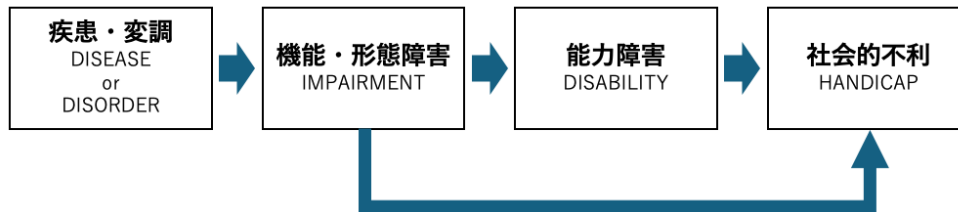


図 2.1: ICIDH の模式図

つを合わせた名称です。ここで機能障害とは、例えば、脳卒中を発症してその結果として生じる言語障害などを指します。形態障害とは、例えば、先天性疾患により一部の指がない場合や成長ホルモンの分泌不全による著しい低身長などがあてはまります。

「能力障害」とは、「流暢に会話ができない」「物を握ることができない」など、生活のさまざまな場面で必要とされる能力が低下している状態を指します。例えば、先ほど例として挙げた指がない場合を考えてみると、指がないという形態障害により「筆記具を握れず、文字を書くのが困難」といった能力障害が引き起こされることとなります。図 2.1 の中に描かれる矢印は、このような障害のレベル間の関係を示唆しています。

「社会的不利」とは、就職の機会を失うとか経済的に困難な状況になる等のより広い範囲での社会参加における問題を指します。先ほど例として挙げた「文字を書くことが困難」という能力障害は、文字を書くことが重要視される職業への就職において不利に働くだろと想像ができます。

図 2.1 では、機能・形態障害から社会的不利に直接矢印が伸びています。ICIDH では、能力障害は引き起こさないものの社会的不利につながるものの例として、形態障害である顔のあざが、就職や結婚における不利（社会的不利）につながるケースを挙げています（上田，2005, p. 11）。

2.2.1.2 ICIDH の背景

ICIDH が発表された背景には 20 世紀後半の社会の状況があります（上田，2002）。この時代には高齢者の数が増加し、また戦争や災害による障害者の数も増加するといった現実がありました。

そうした現実の影響もあり ICIDH が発表される以前から障害者の人権尊重を求める運動は大きくなっていました。実際、1971 年には「精神薄弱者の権利宣言」が国連総会で採択され、そこでは「精神薄弱者は、最大限実行可能な限り、他の人びとと同じ権利を持っている」ことが宣言されています。また、1975 年には「障害者の権利宣言」が出されました。そこでは、障害者は「その人間としての尊厳が尊重される生まれながらの権利を有している。障害者は、その障害の原因、特質及び程度にかかわらず、同年齢の市民と同等の基本的権利を有する。このことは、まず第一に、可能な限り通常のかつ十分満たされた相

当の生活を送ることができる権利を意味する」とされています。

WHO による ICIDH はこれらの人権尊重の考え方を具現化する形で「試案」として発表されたものです。

2.2.1.3 ICIDH への批判や誤解

ICIDH は「完全参加と平等」をテーマとする国際障害者年（1981 年）の行動計画にも取り入れられ大きな影響力を持ちましたが、これに対する批判や誤解も多々ありました。主な批判点として、以下のようなものが挙げられます（上田，2002）。

1. ICIDH は「客観的な障害」に焦点を当てており、悩みや苦しみ、絶望などの「主観的障害」を十分に扱っていない
2. マイナスを減らすことにのみ焦点を当てており、障害がある人のプラスの側面について焦点を当てていない
3. 障害の状態は環境要因によって変わるが、それが考慮されていない
4. 社会的不利の分類が不十分で、障害がある当事者の意見を聞かずに専門家が作ったものである
5. これは誤解に基づく批判ではあるが、ICIDH の一方向的な矢印は、「機能・形態障害が不可避的・運命的に能力障害を引き起こし、それが運命的に社会的不利を引き起こすという運命論であり決定論である」というものである

なお、5 点目については図 2.1 だけを見るとたしかに、一方通行で逆戻りしないイメージを持ってしまいそうですが WHO はこの解釈を明確に否定しています。実際に WHO による ICIDH の本文を見ても、図が載っているページの近くに「逆方向に影響することがある（p.30）」と書いてあり、1993 年の版の序文でも、障害を一方通行のものとして理解することが誤解であることが述べられています。

2.2.2 ICF

前項で紹介した ICIDH は社会的不利を障害に含める等、画期的な点は多かったものの、批判やさまざまな誤解を受けました。前節での批判に応える形で 2001 年の WHO 第 54 回の総会で採択されたものが**国際生活機能分類（ICF）**です。

2.2.2.1 ICF の考え方

ICF における障害の捉え方を図 2.2 に示しました。ICF では、個人の健康に関する情報を 2 つの部門に整理しています。第 1 部は「生活機能と障害」であり、第 2 部は環境因子と個人因子からなる「背景因子」です。図 2.2 では、中段の部分が「生活機能（と障害）」に対応しており、下段の部分を「背景因子」に対応しています。

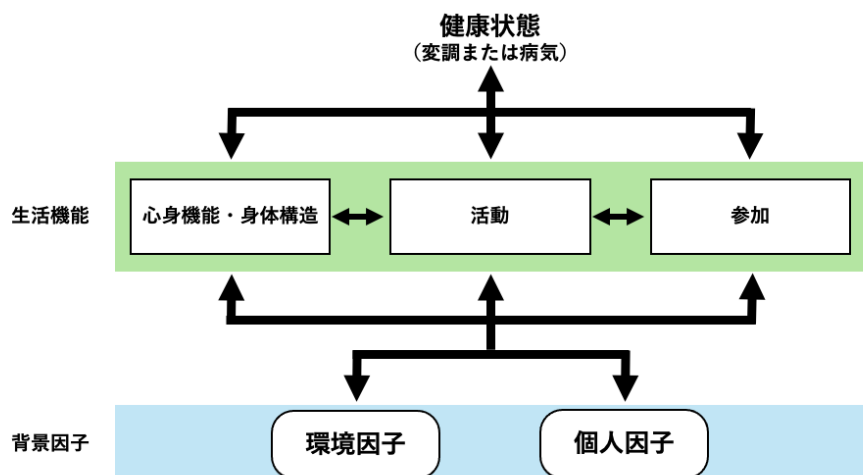


図 2.2: ICF の模式図

まず中段の「生活機能（と障害）」ですが、これは3つの構成要素から成り立っています。これらの構成要素は2つの方法で表現されます。まず、健康状況に問題がない（中立的な）場合には、心身機能・身体構造、活動、参加で表されます。この3つを包括して「生活機能（functioning）」と呼びます。

逆に健康状態に問題がある場合には3つの構成要素はそれぞれ、機能障害＜構造障害＞、活動制限、参加制約で表されます。これら3つを包括する用語として「障害（disability）」が使われます。この障害に対応する3つの要素は、ICIDHにおける機能・形態障害、能力障害、社会的不利を引き継いだものです。これらは図中では省略されています。

ICF では、これまでの ICIDH のマイナス面を評価する枠組みを継承しながらも、個人の状態をマイナス面だけでなく、プラスの面まで含めて包括的に把握できるようにしたものと言えます。そうしたことから ICF は「生きることの全体像」についての「共通言語」と呼ばれることもあります。

ICIDH から ICF への大きな変更点として、環境因子・個人因子という背景因子への注目が挙げられます。図 2.2 では下段にあたる部分にこの変更が反映されています。

環境因子や個人因子がモデルに含まれたことは、生活機能あるいは障害の状態像というのは、様々な要因に影響されるという考えを反映しています。例えば、下半身が動かずに（機能障害）、歩くことができず（活動制限）、大学に通学できない（参加制約）という場面を想定してみたときに、車いすという道具があれば（環境因子）、移動することができ（活動）、学校へと通学できる（参加）といったように、環境因子によってその人の状態像は大きく変わります。別の例をあげれば、読字障害（機能障害）がある学生が、授業の課題の文章を読めず（活動制限）、学校での議論に参加できない（参加制約）場合に、音声読み上げ機能のあるパソコンやタブレットを用いて課題の内容を理解し（活動）、学校で

の議論への参加（参加）できた場合を考えてみましょう。この場合には、読んで理解するという能力障害の問題は解決していないが、聞いて理解するという本人の別の能力を用いた活動で、社会への参加が可能になっています。

これらの例から分かるように、環境因子や個人因子（本人の強み）に注目して状況を把握することで、その人の生活の状況をより詳細に考えることが可能となっています。なお、こうした環境因子には支援器具などの用具から、家族や友人などの態度、サービスや制度などが含まれます^{*1}。

2.3 障害者権利条約と合理的配慮

近年の障害についての国際的動向の中で最も大きな影響を持つものが**障害者の権利に関する条約**（以下、**障害者権利条約**）です。この条約は 21 世紀初の人権条約で、2006 年に国連総会において採択されました。日本政府は翌年 2007 年に署名をして、様々な国内法を整えた上で 2014 年に批准しています^{*2}。

この条約の採択以前にも 1971 年の「精神遅滞者の権利に関する宣言」^{*3}、1975 年の「障害者の権利に関する宣言」、1982 年の「障害者に関する世界行動計画」など、障害者の人権についての国際的な取り組みが行われてきており、一定の影響を持ってきました。しかし、これらの宣言や計画と障害者権利条約には大きな違いがあります。それは障害者権利条約が締結国に対して法的な拘束力を持つことです。この条約が国連総会において採択されたことは、各国の障害者に対する取り組みを推進する点で大きな意義があることでした。

2.3.1 障害者権利条約の特徴

障害者権利条約の特徴として（1）合理的配慮という概念の導入、（2）条約締結国のモニタリングの仕組みがあります。1 点目の合理的配慮の概念は、障害者教育を考える上でも特に重要なので次項で詳しく取り上げ、ここではモニタリングの仕組みについて説明します。

この条約には、条約で定められた事項を各国が実行しているかをモニタリング（チェック）する仕組みが規定に盛り込まれています。具体的には、条約締結国は、締結後に条約

^{*1} 厚生労働省の HP に ICF の日本語版が掲載されているので、そこで環境因子にどのようなものがリストアップされているか見てみるとよいでしょう。

^{*2} 「署名」とは条約の趣旨や内容について基本的な賛意を表明することを意味します。署名後には国会の承認を経て、条約に拘束されることについて国が同意を表明します。このことを「批准」と言います（より正確には批准は締結の方法の一種です）。批准後に条約の効力が発生します。

^{*3} 英語だと Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons ですが、精神遅滞（Mental Retardation）という用語は今では知的障害（disorders of intellectual development）に置き換えられるようになってきていますので、1971 年のこの宣言についても「知的障害者の権利に関する宣言」と書かれていることもあります。

の実施状況をまとめた報告書を作成して障害者権利委員会に報告することが求められています。また報告書に対して出された懸念や疑問点に対して回答を行う必要が締結国にはあります。その後、委員会は**総括所見**を公開する形で各国における条約の実施状況がモニタリングされる仕組みになっています。

日本政府に対する総括所見は2022年に公開され、様々な領域にわたって90項目以上が改善するよう勧告されました^{*4}。総括所見の日本政府による仮訳は[外務省のウェブサイト](#)で読むことができます。なお、日本障害者協議会（Japan Council on Disability）は、ウェブサイト上に各国の国際審査の過程を日本語訳したものを掲載しています。条約の実施状況のモニタリングの実際が知りたい人は見てみるとよいでしょう。

障害者権利条約の特色を表す言葉の一つが「**私たちのことを私たち抜きに決めないで（Nothing about us without us!）**」というスローガンです。スローガンが示唆するように、従来、障害者に関することの決定にも拘らず、障害の当事者がその決定に関与できないことはしばしばありました。実際、前節で紹介したICIDHの作成過程では研究者のみが関わり、障害がある当事者が作成に関与していないという批判がありました（上田，2002，pp. 15–16）。そこで、障害者権利条約では障害当事者が実際に参加して条約の内容や表現について決めていきました。

日本では、障害者権利条約締結に向けた国内法の整備のために内閣に「障がい者制度改革推進本部」を設置し、障害者施策の推進に関する事項について意見を求めるための「障がい者制度改革推進会議」を設置しました。このときの会議の構成員24名のうち14名が障害がある当事者やその家族でした。これはスローガンにあるように障害者施策について障害者当事者が決めていくという条約の理念を反映したものでした。当時の議事録は[内閣府のHP](#)ですべて読めるので興味がある人はぜひ覗いてみると良いでしょう。

パラレルレポート

障害者権利条約における条約の実施状況のモニタリングの仕組みの中に**パラレルレポート**（あるいは代替報告や影の報告）と呼ばれるものがあります（佐藤，2017）。パラレルレポートとは民間団体が障害者権利委員会に対して、各国の民間団体が提出する独自の報告のことを指し、そのためのガイドラインも示されています。こうした仕組みのおかげで、条約締結国の政府による報告書だけでは明らかにできないデータを紹介しつつも、その国の障害者が国の取り組みをどのように評価しているかがモニタリングに含まれることになります。

「私たちのことを私たち抜きに決めないで」という理念はモニタリングの仕組みにも反映されていると言えるでしょう。

^{*4} NPO 法人 DPI 日本会議，[障害者権利委員会から日本政府へ勧告（総括所見）が出されました！ ～90 項目以上改善するよう勧告されています～](#)（アクセス年月日：2024 年 8 月 22 日）

2.3.2 合理的配慮

障害者権利条約の特色の中で最も大きなものが、主要人権条約の中で初めて**合理的配慮** (reasonable accommodation) という文言を用い、さらに、合理的配慮を否定すること（合理的配慮の不提供）は差別であると明確に宣言したことです^{*5}。この合理的配慮という概念は障害者の人権を保障する手段として極めて重要です。

障害者権利条約において、合理的配慮を提供しないことは障害者への差別に当たると考えられています。日本では2013年に制定された「障害者を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（以下、**差別解消法**）において、学校や役所等の行政機関において合理的配慮の提供が法的義務となり、2021の同法の改正において一般の事業者においても義務化されました。

2.3.2.1 合理的配慮とは

内閣府が啓発用に発行しているリーフレット『「合理的配慮」を知っていますか?』では、合理的配慮の提供は次のように説明されています。

i 合理的配慮の提供についての説明

障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。

この法律では、役所や事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたとき（※）に、負担が重すぎない範囲で対応すること（事業者においては、対応に努めること）を求めています。

※ 言語（手話を含む。）、点字、拡大文字、筆談、実物を示すことや身振りなどのサインによる合図、触覚など様々な手段により意思が伝えられることをいいます。通訳や障害のある人の家族、支援者、介助者、法定代理人など、障害のある人のコミュニケーションを支援する人のサポートにより本人の意思が伝えられることも含まれます。

この説明における1つ目のポイントは「社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたとき」の箇所です。合理的配慮というのは、個別・具体的に何かしらのバリアを取り除くために提供されるものだということです。

合理的配慮は社会の中のバリアを取り除くという点ではバリアフリーやユニバーサルデザインなどと近いものもありますが、個別性という点で異なります。バリアフリーやユ

^{*5} 川島 他（2016, p. 22）によればこの用語はもともと1960年代半ばのアメリカや1980年代半ばのカナダで宗教差別に関連した用語として使われ始めました。その後、1990年の「障害をもつアメリカ人法（Americans with Disabilities Act of 1990）」によって世界に広まりました。

ユニバーサルデザインは、対象や状況を限定せずに誰に対しても（事前に）バリアを取り除いておくものなのに対して、合理的配慮は合理的配慮を申請する人が特定の具体的な場面で、その人のニーズに合致するように必要とする調整や変更である点で大きく違います。

説明の2つ目のポイントは「負担が重すぎない範囲で」の箇所です。例えば、車椅子の利用者で2階にあるレストランへと入店できない人が、自分のためにエレベーターを設置してほしいと求めても、店にとっては負担が重すぎるため、この対応をする必要はありません。

ただし、この場合でも店側はレストランへと入店したいという障害のある人のニーズを汲み取った上でどのような対応なら可能かを話し合う必要があります。障害がある人と事業者が行うこのような対話は**建設的対話**と呼ばれます。「負担が重すぎない範囲で」というのは事業者が対応しないための言い訳にはならないので注意しましょう。

障害児教育について考えてみると、学校の文化によっては合理的配慮を検討する際に「前例がありません」や「特別扱いできません」といった理由(?)で、対応がなされないことがあります*6。しかし、こうした対応は内閣府が差別解消法の2021年の改正に際して作成した**リーフレット**においても、**対話の際に避けるべき考え方**として紹介されています。合理的配慮は、障害のある人が教育を受ける権利を保障するものという基本的な考え方に立ち返って必要な対応を検討するべきでしょう。

調べてみよう

内閣府の**リーフレット**を参照して、合理的配慮の具体例や建設的対話の具体例を確認してみましょう。

合理的配慮という語について

合理的配慮という語の「配慮」という語が日本語だと「やってあげる」ニュアンスを含むため、この訳語があまり適切でないという議論があります。

小林・原田（2013）は reasonable accommodation の意味を正しく表現するために「現実的な調整」「理性的かつ変化し得る妥協」「双方合意の適切な環境調整」「相互努力による適度な調整」といった訳語を提案しています。この概念を理解するときには、「配慮」という言葉に引きづられないことが重要でしょう。

*6 以前、特別支援教育に関する巡回相談の仕事をしていたときに実際にこのような反応をされることは多かったです。

2.4 補足

2.4.1 社会モデルとICFの関係について（★）

ICF はしばしば、医学モデルと社会モデルとを止揚した**統合モデル**だと呼ばれることもあります。これはICFの図2.2にあるように、障害は機能障害のみが原因で生じると考えるのではなく、機能障害と社会的障壁（図だと環境因子に含まれる）の相互作用によって生じるものだとICFでは考えることを反映しています。この相互作用は図2.2だと両方向の矢印によって示されています。

ICFによる統合モデルは、機能障害と社会的障壁をどちらも障害の原因として平等に重視していますが、それは社会モデルにおける考え方とは大きく異なっています。川島（2024）によれば、英国の社会モデルでは、障害の原因性（問題性）を形式的にも実質的にも社会的障壁にあると考えます。また、米国の社会モデルでは、形式的には障害の原因が相互作用にあるとしますが、実質的には社会的障壁の問題を強調するので、英国／米国いずれの社会モデルの立場をとるにせよ、機能障害と社会的障壁のどちらも平等に（中立的に）重視するICFとは障害の原因の見立てが異なります。

統合モデルであるICFが機能障害も社会的障壁もどちらも「中立的に」重視しているというのは一見魅力的に聞こえますが、危険性も孕んでいます。障害の原因を機能障害に求める医学モデルが支配的な価値観である現代の社会においては、障害の原因として機能障害も社会的障壁も中立的に重視すると言った場合には、それは結局医学モデルを助長することにつながる可能性があります（川島，2024）。

2.4.2 理解を深めるための資料等（★）

- [Educating Peter](#)

1992年のアカデミー章短編ドキュメンタリー映画賞を受賞した作品です。ダウン症がある小学校3年生ピーターが通常学級に転籍した1年のドキュメンタリー映像です。最初は教室の中で問題を起こしていたピーターが適用して徐々に周りの児童たちを変えていった様子が描かれています。

障害がない子どもとある子どもが一緒に学ぶインクルーシブ教育のポジティブな面を象徴的に描く一方で、サクセスストーリーとして描きすぎている、成功のために必要とされる人的な支援や環境的な支援について描かれていない等の批判もあったようです（水内，2023, p. 59）。

※ 設定ボタンから自動翻訳機能をつかって日本語字幕をつけることもできます。

第3章

障害者の権利と当事者運動

今回は障害者福祉において重要な概念であるノーマライゼーションおよびそれを達成するための当事者たちの運動を見ていきます。

3.1 ノーマライゼーション

障害者福祉においてノーマライゼーション（normalization）という考え方があります。ノーマライゼーションは、普通を表す「ノーマル」と「～にすること (-ization)」を組み合わせた造語で、障害者福祉において重要な概念として扱われてきました。もともとは北欧の障害者施策から出てきた概念ですが今では広く世界で使われています。ここではノーマライゼーションの概念の普及に貢献した3人を河東田（2008）を参考に紹介していきます。

3.1.1 バンク・ミケルセン

ノーマライゼーション（Normalization）はデンマークの行政官であるバンク・ミケルセン（Bank-Mikkelsen）によって提唱された概念です。石渡（1997）によれば、1950年代には知的障害者は一般社会とは遠く離れた「コロニー」と呼ばれる大きな施設で暮らしていましたが、指導する「権力」を持った強い職員と弱い知的障害者という構造が生まれ人権侵害の場となっていました。そうしたことに気づいた知的障害者の親の会は、隔離された施設への反対運動を起こすことになりましたが、この親の声を聞き1959年に「精神遅滞者福祉法」と呼ばれる法律を立法化したのがバンク・ミケルセンです。

この法律では知的障害者の脱施設化を進めるためにデンマークを12の地域に分けて地域センターを設置して地域生活をサポートすることなどが盛り込まれました（Bank-Mikkelsen, 1969）。1959年の法によって行われるサービスは、知的障害者の生活を「ノーマルにする（normalize）」ことが目的であると明記されました。ここで「ノーマルにする」

とは、**知的障害の人をノーマルな人にする**ことを意味するのではなく、**知的障害のある人のノーマル生活条件を提供する**という意味なので注意が必要です。

ちなみに知的障害者の隔離施設の一つである Andersvænge について次の[ウェブサイト](#)が写真付きで紹介しています。現在では当時の記録を残す歴史博物館となっているようです。ウェブページ自体は英語ですが、写真で雰囲気だけでも分かるので覗いてみると良いでしょう^{*1}。罰の手段として固定具が使われた生々しい写真などが載っています。

3.1.2 ニイリエ

バンク・ミケルセンのノーマライゼーションに影響を受けながら、その考えを発展させノーマライゼーションの原理として8つにまとめたのがスウェーデンのニイリエ（Nirje）です^{*2}。ニイリエが示したノーマライゼーションの原理とは、所属するコミュニティや文化における普通の生活の条件を示したものです。その人に障害があっても可能な限り以下にあるような生活条件を求めるものとされます（Nirje, 1969, 1999）。

- **1日のノーマルなリズム**：朝ベッドから目が覚めて、着替えて、家族と朝食を食べる。知的障害だからといって早く就寝する必要はない。
- **1週間のノーマルなリズム**：平日は職場や学校に行き、余暇活動では様々な場所に行く。知的障害があるからといって訓練施設やセラピーなど特定の場所のみで生活する必要はない。
- **1年間のノーマルなリズム**：休暇の期間に旅行に行って心と身体を癒す、など。
- **ライフサイクルにおけるノーマルな発達の経験**：少年期から青年期を経て、成人期を迎えて、大人として尊敬されるようになること。
- **ノーマルな個人の尊厳と自己決定権**：自分自身で余暇のプログラム、クラブ活動への参加などを選べる。知的障害があるからといって、16歳や18歳にもなって子どもキャンプに参加する必要はない。
- **その文化におけるノーマルな性的関係**：知的障害があるからといって、男女を不必要に分けて活動させられずに、日常生活のノーマルなパターンで関わる機会がもたらされる。
- **その社会におけるノーマルな経済的水準とそれを得る権利**：一般市民と同じような経済水準での生活ができる。そのための基本的な経済的な措置がなされること（児童手当や個人年金など）。
- **その地域におけるノーマルな環境形態と水準**：一般の市民が使う施設と同種の物理的設置基準にそった病院、学校、グループホームなどが使える（例えば、狭すぎる空間に多数が詰め込まれない）

^{*1} 英語が得意な人は読んでもらおうと良いですし、最近だと自動翻訳もだいぶ発展していますので、それを使うのも良いでしょう。

^{*2} 文献によっては、ニルジェやニーリエとも表記されます。

なお、ニィリエのノーマライゼーションの考え方は後に国連の行動計画の中でも取り入れられていきます。このことから、バンク・ミケルセンを「ノーマライゼーションの生みの親」、ニィリエを「ノーマライゼーションの育ての親」と呼ぶこともあります。

3.1.3 ヴォルヘンスベルガー

北欧で生まれたノーマライゼーションの考え方は、ドイツ生まれで後にカナダ・アメリカに渡ったヴォルヘンスベルガー（Wolfensberger）によって独自の発展を遂げることとなります。バンクミケルセンやニィリエのノーマライゼーションでは、生活環境をノーマルにすることに焦点が当てられていましたが、ヴォルヘンスベルガーは障害のある人が社会から価値を低められていることこそが問題であると捉え、社会における価値ある役割を作ることを重視しました。そこで、北欧で生まれたノーマライゼーションの原理を次のように定義し直しました。

可能なかぎり、文化的に通常である身体的な行動や特徴を維持したり、確立するために、可能なかぎり文化的に通常となっている手段を利用すること（訳は 河東田, 2008, p. 88)

ヴォルヘンスベルガーのノーマライゼーションは、「文化-特定の」だとされます。文化-特定のとは、異なった文化では「通常」の意味するものが違うため、特定の文化には特定の通常があるということを指します。例えば、成人したらほぼ全員が親元を離れてくらす文化と成人後も一緒に暮らし続ける文化があったとしたら、成人期のノーマルな生活の意味は2つの文化で異なるでしょう。ヴォルヘンスベルガーは、北欧のノーマライゼーションにおけるノーマルな生活条件を北アメリカの文化に適用できるように再概念化したとされています。

ヴォルヘンスベルガーは、障害のある人の社会的な価値を高めるために、(1) 知的障害者自身の能力を高めること、(2) 知的障害者のイメージを高めるための社会に対する働きかけの2つを重視しました（佐藤・小澤, 2010）。そのために福祉サービスを評価するための枠組みである PASS（Program Analysis of Service Systems）や、それをさらに発展させた PASSING（Program Analysis of Service Systems Implementation of Normalization Goal）と呼ばれるものを次々に開発して、理念だけでなく具体的な取り組みや評価ができるようにしたことで注目を集めることとなりました。

なお、ヴォルヘンスベルガーのノーマライゼーションの背景には、当時のアメリカの脱施設化政策が上手くいっていなかったことが背景にあります。アメリカでは施設の入所者数は1960年代にピークを迎えましたが、ノーマライゼーションの考えの浸透とともに脱施設化の政策が進められていました。しかし、施設を退所した障害者の地域生活が困難で再入所するということが多く、単に脱施設化を進めるだけでは不十分であったということが、ヴォルヘンスベルガーが社会における価値の問題を扱うことに向かわせたようです。

当時のアメリカでの障害者施設的环境は劣悪だったようで、その様子を隠しカメラで撮り写真エッセイにした『煉獄 (れんごく) のクリスマス (Christmas in Purgatory)』という本が1966年に出版されました。この本は現在 Web 上で公開されており、タイトルで検索をすると施設での生活の様子を見ることができます。

3.2 自立生活運動

障害者の生活について考えるにあたり1960年代のアメリカで誕生し、1970年代に活発になった自立生活 (independent living, IL) 運動は重要なものです。

3.2.1 運動の起こりとその発展

この運動の発端は「自立生活運動の父」と呼ばれるエド・ロバーツ (Edward Roberts, 図 3.1) がカリフォルニア大学に入学した1962年だとされています (石渡, 1997)。彼はポリオの後遺症で、首から下が全てマヒであったため、電動車いすを利用していました。また、肺にも障害があり「鉄の肺」と呼ばれる人工呼吸器を使っていました。障害が重かったために、学生寮に入らずキャンパス内の病院から通学していましたが、その話を聞き重度の障害がある学生が集まるようになりました。

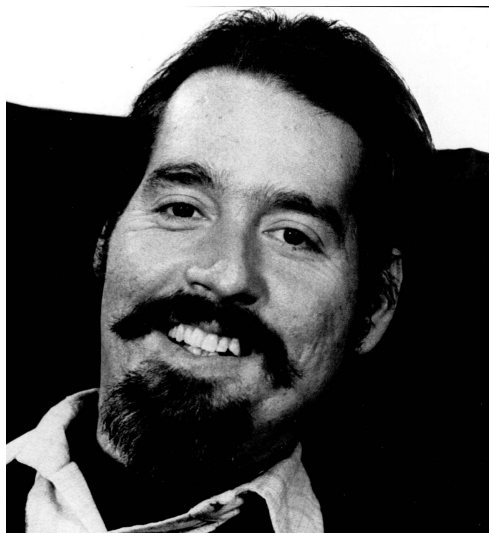


図 3.1: エド・ロバーツ (パブリックドメイン)

エドは学内の仲間とローリング・クワッズ (Rolling Quads) と呼ばれる学生グループを作り、大学と交渉を行いました。また、障害がない学生たちと同じように学生生活を送るために必要なサービスを自分たちで考えていくようになります。具体的には、障害学生の相談に障害学生が応じるピア・カウンセリングや、車イスの修理や、アパート探し、介助者の紹介等が含まれます。

彼は 1972 年にカリフォルニア大学を卒業する際に、彼の仲間たちが地域の中に設立した自立生活センター（center for independent living, CIL）の代表となります。自立生活センターでは、それまでキャンパス内でのみ提供されていたサービスを、キャンパス外の地域で提供することによって、障害がある人が地域で生活することをサポートするようになっていきました。その後、1978 年には「自立生活のための包括的サービス」プログラムが議会で成立し、自立生活の促進のための運営補助金が得られるようになったことも関連して、自立生活センターの数は 1980 年代後半には 300 を超えるようになりました（Scotch, 1989）。

3.2.2 自立生活運動における「自立」とは

自立生活運動における「自立」とは全てのことを自分自身でできるという意味ではありません。このことは、この運動の代表的な規定である以下の文言にも表れています。

障害者が他の手助けをより多く必要とする事実があっても、その障害者がより依存的事であることには必ずしもならない。人の助けを借りて 15 分かかって衣服を着、仕事にでかけられる人間は、自分で衣類を着るのに 2 時間かかるために家にいるほかはない人間より自立している（訳は 定藤 他, 1993, p. 8）。

自立生活運動は「自立」の持つ意味を大きく変えた点で画期的でした（上田, 1983）。自立生活運動以前は、自分の身の回りのことができる「日常生活動作（activity of daily living, ADL）の確立」を目指し、その上で「職業的自立」を目指すことがリハビリテーションのゴールとされていました。しかし、自立生活運動においては、たとえ介助が必要な障害者であっても社会的な役割を果たすことができれば社会的に自立していると考えたのです。

この思想はそこからさらに進み、生活の全てに介助が必要な重度の障害者であっても、日々の生活の中でそのようにしたいかを**選択**して**自己決定**をすることが尊重されていれば、人格的には自立しているのだと考えるようになりました（障害がある人の意思決定の問題は第 9 章でも再度考えます）。したがって、自立生活運動においては「生活の質（quality of life, QOL）を充実」するという意味での自立が重要な意味を持っています。

できないことについては他者の介助や援助を借りながらも、その人らしい生き方を自分で決定して過ごすことが、自立した生活であるという自立生活運動の理念からは学ぶものが多いでしょう。障害者教育（特別支援教育）においても「自立」というキーワードは頻出します。その際にどのような形の「自立」を目指すのかによって教育や支援の方向性は大きく変わることでしょう。

3.3 青い芝の会とその運動

前節の自立生活運動の中心はアメリカでしたが、日本においても 1970 年代に**青い芝の会**という脳性マヒ者の当事者団体が障害者差別と闘い、権利のために活動を行いました。ここでは青い芝の会の活動を通じて、障害者の自立について考えてみましょう。以下の記述は、荒井（2020）や横塚（2007）を参考にしましたが、当時の歴史的背景等を知りたい方はそれらの参考文献を参照してください。

3.3.1 会の起こりと神奈川県連合会

青い芝の会は 1957 年に結成されました。この団体を結成したのは、脳性マヒ者の山北厚、高山久子、金沢英児で、いずれも肢体不自由児のための学校である東京私立光明学園の卒業生でした^{*3}。初期の青い芝の会は裕福な家庭で育った障害者が多かったようで、親睦のためのレクリエーションや就学できなかった脳性マヒ児むけの塾の開設など、比較的穏やかな活動をしていました。

その後、1960 年代には活動内容の幅も広がっていきます。脳性マヒ者が生活していくためには社会の状況を変える必要があるため、行政への陳情など社会問題に対して訴えかけていく活動も行うようになります。例えば、障害福祉年金の増額や障害等級認定の見直しなどを主張しました。

青い芝の会は支部制度を採用していたので、各地方に小さな支部がありました。これらの支部は、陳情や啓発、親睦や互助といった活動に力を入れていましたが、1969 年に結成された神奈川県連合会^{*4}はそれまでの支部の活動とは大きく異なる活動を展開します。障害者差別に対して、具体的な抗議活動を繰り広げることになるのです。

3.3.2 障害児殺害事件への減刑嘆願への抗議活動

青い芝の会の活動を有名にしたものの一つが 1970 年 5 月に起きた障害児殺害事件に対する判決への抗議活動です。

横浜市金沢区で当時 30 歳であった母親が脳性マヒの 2 歳の長女をエプロンのひもで絞殺するという事件がありました。長男にも脳性マヒがあり、また、父親は単身赴任で母親が主に育児と介護にあたっており、当時施設には空きがなかったため預けることができずに介護疲れの末の犯行でした。

^{*3} 光明学園は日本ではじめて開設された公立の肢体不自由児の学校です。現在は東京都立光明学園になっています。

^{*4} 連合会となっているのは、神奈川県に一つの支部があった訳でなく、いくつかの小さな集まりがあり、それらのとりまとめのような位置付けだったからです。

この事件に対して、地元町内会から刑の減刑を求める嘆願運動が起きました。当時の刑法では殺人は3年以上の懲役でしたが、裁判所は情状酌量を認めて懲役2年、執行猶予3年の判決を出しました。

この判決に対して猛烈な抗議活動を行ったのが青い芝の会でした。「障害があるまま生き続けるより殺された方が幸せ」という考えを真っ向から否定し、街頭に立ち「私たちが殺すな」と訴えたのです。そしてこの殺害事件が生じた背景には、社会の障害者に対する偏見と差別があり、それと戦わなければならないのだと主張しました。

なぜ彼女〔引用者注、母親〕が殺意をもったのだろうか。この殺意こそがこの問題を論ずる場合の全ての起点とならなければならない。彼女も述べているとおり「この子はなならない。こんな姿で生きているよりも死んだ方が幸せなのだ」と思ったという。なおるかならないか、働けるか否かによって決めようとする、この人間に対する価値観が問題なのである。この働かざるもの人に非ずという価値観によって、障害者は本来あってはならない存在とされ、日夜抑圧され続けている。

障害者の親兄弟は障害者と共にこの価値観を以って狭ってくる社会の圧力に立ち向かわなければならない。にもかかわらずこの母親は抑圧者に加担し、刃を幼い我が子に向けたのである。我々とこの問題を話し合った福祉関係者の中にもまた新聞社に寄せられた投書にも「可哀想なお母さんを罰するべきではない。君たちのやっていることはお母さんを罪に突き落とすことだ。母親に同情しなくてもよいのか」等の意見があったが、これらは全くこの”殺意の起点”を忘れた感情論であり、我々障害者に対する偏見と差別意識の現われといわなければなるまい。これが差別意識だということはピンとこないかもしれないが、それはこの差別意識が現代社会において余りにも常識化しているからである（横塚，2007, p. 42）。

3.3.3 川崎バス闘争

青い芝の会を全国的に有名にしたものの一つが「川崎バス闘争」と呼ばれる抗議活動です。ここではこの活動の概要および背景について検討します。この活動については荒井（2020）や廣野（2015）が詳細に検討していますので、詳しく知りたい方はそちらも参照してください。

3.3.3.1 概要

川崎バス闘争とは、1976年から1978年にかけて青い芝の会の会員が行った一連の抗議行動を指します。この抗議行動は、当時車いすの身体障害者がバスに乗る際には、（1）介助者が付き添いの上で、（2）車いすは車内で折りたたみ、（3）身体障害者は車いすを離れて座席で座って乗車しなければならないとして、一人でバスに乗ることを認めなかった市の交通局とバス会社への反発として行われたものでした。青い芝の会は、この抗議行動を通じて、車いす利用の身体障害者が介助者なしで一人で移動する権利があることを強く訴え

ました。

抗議行動は、複数回にわたって行われました。具体的には介助者とともにバスに乗り込んだのちに、バス内で車いすを広げて身体障害者は車いすに乗り、介助者は降りて身体障害者が一人で乗車をしようとしてしました。バスの運転手やバス会社は安全性が確保できないことを理由に、車いすから降りて座席に座るように車いす利用者に指示をしましたが、それには従いませんでした。結果として、バスは出発できず運行がストップしてしまい混乱が生じました。

川崎バス闘争の中で最も大規模なものは1977年4月12日に川崎駅のバスターミナルで行われたものです。これについて、翌日の新聞は次のように報じています^{*5}。

同日〔4月12日〕午後一時すぎ、川崎市川崎区駅前本町の国鉄川崎駅東口ターミナルで、「日本脳性マヒ者協会全国青い芝の書い総連合会」（横塚晃一会長、事務所・川崎市高津区子母口）の会員や支援グループの約百人が停車中の川崎市営バスに一斉に分散して乗車した。約四十人の車いすの人たちは、介護人に抱かれたり、車いすごと持ちあげてもらって乗り込んだ。

運転手は「車イスから降りて座席にすわるように」と呼びかけたが、身障者たちは「こっちの方が安全だから」と主張して車イスから降りなかった。

このため、バス側はすでに乗車していた乗客に降りてもらい「危険で運行できない」と、これらのバスの運行を打ち切った。

約一時間後の午後2時には川崎市営バス十二台、臨港バス十八台、東急バス三台が広場内で運転をストップした。

午後二時過ぎ、身障者の一人がバスの中の工具箱から金ヅチを出して市営バスの窓ガラス三枚を割り、午後三時過ぎには、別の市バス内で消火器から車内に消火剤が放出された。

午後五時過ぎラッシュを迎え、第二京浜国道方面へのバスは川崎駅前の次の「明治製菓前」を始発停留所にして運行を始めた。ところが、午後五時五十分ごろ今度はここで東急バスに身障者が乗り込み、駅前を含めて十九台のバスが運行ストップになった。

一方、バス会社や川崎市交通局は、職員を動員してバスが到着するたびに乗車口を囲み、一般乗客だけを乗せる「防衛策」をとって運転確保に当たった。夕方までに約三十台が運行打ち切りになったあとは、入ってくるバスは混雑で遅れたりしながらも、どうやら運転を続けたが、ダイヤは大幅に乱れた。

この騒動は、最終的には警察署員も出動し、力づくでの排除が夜まで続いて、午後11時台にようやく騒ぎが治りました。

*5 朝日新聞 1977年4月13日朝刊

3.3.3.2 バス闘争の背景

青い芝の会のメンバーによるこうした抗議行動は、突発的に生じた訳ではありませんでした。こうした過激な行動は単なる話題作りや闇雲な乗車拒否への抗議ではなく、身体障害者がバスで一人で移動できる権利を保障するための長期的な運動の一環であり、青い芝の会は市の交通局や陸運局とも粘り強く交渉を重ねていたことが指摘されています（荒井、2020）。

この抗議行動より遡って 1970 年代前半には、青い芝の会の会員たちは日常的に路線バスを利用していたようです。その際には、運転手が乗り口の幅の広い降車口から入ることが暗黙の内に認めて利用することができていました。

ところが、1976 年に青い芝の会の支部である川崎市脳性マヒ者教会の会長に矢田龍司が選出されると、車いすの脳性マヒ者が積極的に街に出ていく活動を推奨するようになります。その結果として、会員が地域の路線バスを利用する機会が増え、バスの運転手が車いすの利用者を介助する機会と負担が大きく増えました。

この状況を受けて、川崎市交通局、市営バス、民間バス会社は、車椅子利用者がバスを利用する際には、介護者の付き添いのもと乗車口から車椅子を折りたたんで乗車して、座席に座らないとバスの利用はできないという方針を打ち出しました。この方針に対して、以前のように無条件で乗せるべきだと青い芝の会は抗議を行なっています。

青い芝の会は実際に車椅子のままバスに乗り込む抗議行動だけでなく、市の交通局やバス会社側と交渉も行なっていました。1977 年 4 月に川崎駅ロータリーでの抗議行動を起こす 3 ヶ月前の 1977 年 1 月 7 日には、川崎市脳性マヒ者協会（青い芝の会の支部）と川崎市交通局が話し合いを行なっています^{*6}。そこでは、協会が希望した場合に車いすを折り畳まずに乗せること、民営バス会社に対して車いすのまま乗れるように指導すること、車いすの乗車制限を明文化した運輸規則を改正すること、運輸省などの上部機関が認めるまで市独自で車いす乗車を実施することを求めました。しかし、市交通局はこれに対して要望の検討を進めるとして、結論は先延ばしになりました。

また、青い芝の会は市交通局とだけでなく、陸運局とも交渉を重ねています（廣野、2015）。同年 1 月 27 日に車いすのままでの乗車を求める要望書を出し、また 2 月と 3 月に東京陸運局との交渉の場を持っています。しかし、陸運局は交通局の責任者を交渉の場に同席されると約束したものの、その約束は果たされずに、次の交渉の日程も決まらず交渉は停滞しました。この交渉の停滞が、4 月 12 日の大規模な抗議行動へとつながっていきました。

その後、1977 年 10 月に青い芝の会は運輸省陸運局と話し合いの場を持ち、「車いすに座っ

^{*6} 朝日新聞 1977 年 1 月 8 日朝刊

たまま障害者が乗車する」ことについては合意に達しました^{*7}。翌年の1978年3月には、運輸省は、介護者がいて、乗降口の一定の幅（80cm以上）が確保されていれば、車いすのまま乗車することを認め、その際の基準を発表したと朝日新聞が報じています^{*8}。

ただし、新聞記事でも触れられているように、青い芝の会は運輸局が出した基準の内「介護人同伴」には強く反発していました。特に、交渉の過程で会が強く反対していたのは「介護人を特定する」という点で、これにより障害者が一人で自由に生活することの制限につながることを危惧していました。当時、車いすの身体障害者の介護は家族や施設職員が主でしたが、介護者を特定の人にするということは、介護人がつけられる範囲に生活の幅が狭められ、また、介護人が必ずしも障害者の意思に従うとは限らず、その結果自分の意思によらない生活を強いられるリスクがありました（廣野，2015）。車いすの身体障害者が自分の意思で自分の生活を決めるという点から見たときに、介護人の同伴によらないバス乗車は譲れない条件でした。

運輸規則は1999年に改正されて、現在では介護者がいなくともバスに乗ることができます。しかし、障害者が交通の面で不自由がなくなった訳ではありません。比較的最近の話だと、格安航空会社のバニラ・エアに車いす男性が乗車しようとしたところ乗車拒否されたことが問題となったり^{*9}、車いすでJRの無人駅を利用しようとしたところ職員から案内できないとされたことをブログに書いた車いすユーザーに対して「わがまま」との批判が多数寄せられたりするなど^{*10}、交通のバリアフリーは解決している訳ではありません。こうした問題について考える際に、青い芝の会の主張は参考にするべき点が多々あるでしょう。

3.4 補足（★）

3.4.1 理解を深めるための資料等

- 街へ出よ－福祉への反逆－ [\[前編\]](#) [\[後編\]](#)

全国青い芝の会のドキュメンタリー映像です。1977年4月川崎駅バスロータリーでの実際の様子を見ることができます。

- こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話 [\[予告編\]](#)

難病である筋ジストロフィーの鹿野靖明がボランティアに支えられながら自立して生活をする様子を描いたノンフィクション作品です。大泉洋が主演で映画化されています。典型的な障害者像と大きく異なるので、障害者に対して持つイメージが変わるかもしれません。

^{*7} 朝日新聞 1977年10月22日朝刊

^{*8} 朝日新聞 1978年3月28日朝刊

^{*9} 朝日新聞 2017年8月7日朝刊

^{*10} 朝日新聞 2021年4月10日朝刊

第4章

日本における特別支援教育の歴史と制度

日本における障害がある子どもの教育は特別支援教育という枠組みで行われています。ここでは簡単にその歴史を振り返ってみます。便宜的に障害児教育の歴史を（1）戦前の教育、（2）戦後の特殊教育、（3）2007年以降の特別支援教育と3つに区切って説明します。なお、以下の記述全体については文部科学省（2022）の『学制百五十年史』を^{*1}、戦前および戦後については平原（1979）を参考にしました。

4.1 戦前の障害児教育

日本において障害児向けの教育機関が最初に出来たのは明治時代（1868–1912）のことです。この時代は、障害児教育の制度が公的には整っていなかったため、大きな役割を果たしたのは民間の篤志家でした。

1872年（明治5年）に学制が発され、近代的で体系的な教育制度が始まります。学制では、欧米の障害児学校をならって「其外廃人学校アルヘシ」と小学の種類として障害児向けの学校について一応規定はされていたようですが、実際にはその実施はなされませんでした。またこの規定の廃人学校というものがどんなものかは説明されていないため、その詳細は分からないようですが、他の資料からは廃人学校は盲学校や盲啞（もうあ）学校のことを指していたようです（平原，1979）。

4.1.1 盲教育および聾啞教育

日本で最初に設立された障害児向けの学校は1878年（明治11年）の京都盲啞院で、最初の聴覚・視覚障害児のための学校だとされます。この学校の前身は上京第19区を管理す

^{*1} 内容は[文部科学省のホームページ](#)で全て読むことができます。

る熊谷伝兵衛という篤志家が設けた癩哑（いんあ）教場だとされています（平原，1979）。ここで，1874年（明治7年）に聾（ろう）児3人の教育を担当した古河太四郎（図4.1）が，その後京都盲哑院の初代校長となります^{*2}。

また，同じ頃，東京では盲教育のための組織「楽善会」が1875年（明治8年）に発足し，1880年（明治13年）に楽善会訓盲院が設置されました。これらの学校はその後，それぞれ市立盲哑院（明治22年），東京盲哑学校（明治20年）と改組されていくことになりました。



図4.1: 古河太四郎（パブリックドメイン）

これらの動きを受けて，特殊教育を行う学校の整備を求める声が高まりました。その声に応じる形で，明治23年の第二次小学校令で「盲哑学校」は小学校に準ずる学校として規定されました。また，明治33年の第3次小学校令において義務就学について規定されましたが，障害児については修学を免除もしくは猶予すると規定されました。

4.1.2 知的障害教育

4.1.2.1 滝乃川学園

知的障害がある子どもへの教育について，石井亮一（図4.2）が東京の滝乃川学園で明治39年に知的障害の教育を開始しました。以下では加藤（1986）の記述を参考に，その初期

^{*2} 岡本（1978）によれば，古河は明治3年の夏から2年間，帯刀および工事の許可書の偽造で徒刑（ずけい、今で言う懲役に似たもの）を経験しています。この獄中で陵辱される聾児を見たことが古河の盲聾教育の動機になったようです。

の教育について説明します。



図 4.2: 石井亮一（パブリックドメイン）

滝乃川学園の前身は 1891 年（明治 24）に、罹災孤女の教育を行うために設立された孤女学院でした。この学院の収容孤女の中に知的障害がある女兒がいて、石井がその教育に苦心したことが後の知的障害教育を始めるきっかけとなったと言われています。1897（明治 30）年には学園の名前を滝乃川学園と改称しています。

知的障害の子どもの募集は 1897（明治 30）年ごろから開始をしました。入園者は少なかったものの徐々に増加して、1902（明治 35）年には知的障害教育の施設として本格的なスタートをきったとされています。1905（明治 38）年には、校舎を東京府北豊島郡に移転させています^{*3}。

滝乃川学園で行われていた教育はどのようなものだったのでしょうか。知的障害児の教育方法を探るために、石井はアメリカで 7 ヶ月間の研修を受けています。この研修の成果を生かして、日本で最初の知的障害児向けの専門書である『白痴児，其研究及教育』（石井，1904）という専門書も刊行しました^{*4}。

^{*3} 余談ですが、このホームページによると、1920（大正 9）年に学園は火事で被災して、石井夫妻は学園を閉鎖しようとしたようです。しかし、現在の千円札にもなっている渋沢栄一の長女が石井筆子と同級生であつたらしく、渋沢栄一が援助を申し出たようです。後に渋沢は学園の理事長にもなっています。

^{*4} この本は『日本児童問題文献選集』の 18 巻に収録されており、国立国会図書館によってデジタル化されています。

4.1.3 肢体不自由児と病弱児

肢体不自由児のための養護施設としては、体育教師であった柏倉松蔵が私財を投じて設立した東柏学園が東京で1921（大正10）年が初期の教育を行なっています。また、肢体不自由児のための学校としては昭和7年に東京市立光明学園がありました。

身体虚弱・病弱児の指導はそれらよりも遅れて、大正中期以降に整備されました。恒常的な養護・教育施設として東京養育院安房分院（明治42年）であったり、養護学校としては茅ヶ崎の林間学校（大正6年）が知られています。栄養学級・養護学級の名前で虚弱病弱児の学級は全国に増えていきました。

4.1.4 戦時下の教育

戦時下の1941年には国民学校令が出されます。その中で知的障害児については、「身体虚弱、精神薄弱其ノ他心身ニ異常アル児童ニシテ特別養護ノ必要アリト認ムルモノノ為ニ学級又ハ学校ヲ編制スルコトヲ得」と規定されています。この令により、養護学級・養護学校（今の特別支援学級・特別支援学校）という名称が使われるようになります。

また、それまで小学校だけであったものが、中学校や高等女学校でも養護学級を編成ができるようになります。しかし第二次世界大戦の戦局の進行とともに閉鎖が増えていきました。

4.2 特殊教育

第二次世界大戦後に連合国の占領管理下を経て、日本の教育制度は新たなスタートを切ることとなりました。日本国憲法が1946（昭和21）年に公布され、その中で「教育を受ける権利」が国民の基本的人権の一つとして明記されることとなります。翌1947（昭和22）年には国の教育に関する基本的理念と原則を定めた「教育基本法」および戦後の学校教育の方向性を示した「学校教育法」が公布され、戦後の教育改革が進んでいくことになります。

この新たな制度のもとで障害児への教育は**特殊教育**（special education）と呼ばれる形で、公的な制度へと組み込まれていきます。具体的には、学校教育法で特殊教育を行う学校は、「盲学校」「聾学校」「養護学校」の3種類が設けられ、その設置が都道府県に義務付けられました^{*5}。それぞれの学校には幼稚部、小学部、中学部および高等学校が置かれ

^{*5} 従来使われていた「聾啞学校」が「聾学校」に改められた経緯については、「啞」という現象のほとんど全部は、その原因が聾にあるので、発声器官の故障によるものではない、しかも口話法の発達によって、聾者は、啞者とならずにすむことが実証されているのであるから『聾啞』という状態は、聾教育の進展とともに消滅するのだという、聾教育界の年来の主張が採用（文部省、1958、p.38）」されたためだとされます。

ることとなりました。また、これらの学校に加えて、小学校、中学校、高等学校に**特殊学級**を置くことができるようになりました。

4.2.1 盲学校・聾学校教育の義務化と養護学校の整備の遅れ

戦前の障害児教育の体制として、知的障害児や肢体不自由児のための養護学校に比べて、盲学校や聾学校の取り組みが進んでいたため、就学の義務化の実施については盲学校や聾学校が先行して行われました。学齢に達した盲児、聾児の修学を義務付けて、その後は学年進行することにより完成を目指す方式がとられました。

一方で、養護学校については新制度の開始とともに就学義務化の実施は達成できませんでした。その原因には、養護学校教育の実績がなく、施設設備の整備が遅れていたことや、教員養成が遅れていたことに加えて、盲・聾学校と養護学校の扱いが違って当然とする周囲の雰囲気があったことが指摘されています（平原，1979，p.9）。

養護学校の義務化の実施については盲・聾学校から遅れましたが、文科省は1972（昭和47）年度から「特殊教育拡充計画」を策定して、7年計画で養護学校の整備を進めました。その結果、1978（昭和53）年には全国で500を超える養護学校に通う児童生徒の数は5万人を超えるようになりました。学校の整備ができたことを踏まえて、1979（昭和54）年度から養護学校の義務制が実施されることになりました。

4.2.2 通級による指導の制度化

重度の障害がある児童・生徒が通うための盲学校、聾学校、養護学校は整備されていきましたが、軽度の障害児のための教育の充実は課題となっていました。そこで、文科省は1990（平成2）年に「通級問題に関する調査研究」を開始して、1993（平成5）年の協力者会議の答申を経た上で学校教育法施行規則を改正し、言語障害、情緒障害、弱視、難聴等がある児童生徒を対象に、**通級による指導**という教育形態を制度化しました。

通級による指導とは、小学校、中学校の通常学級に在籍する障害児が、障害に応じた特別な指導を、通級指導教室といった特別な場で受ける形態の指導を指します。通級指導教室では、教員の高い専門性のもとで個別のきめ細やかな指導をうけることが可能となりました。

なお通級指導の対象はその後2006（平成18）年の法改正で、発達障害である学習障害（LD）や注意欠陥多動性障害（ADHD）の児童・生徒も対象に含めるようになりました。また、それまで対象であった情緒障害には（1）自閉症と（2）選択性かん黙等が含まれていましたが、これらは原因および必要な指導が異なることが明らかとなったため、自閉症は独立して対象に追加するとともに従来の（2）のみを対象に情緒障害とするように分類が改められました。また、2018（平成30）年からは、高等学校でも通級による指導が行わ

れるようになっていきます。

4.3 特別支援教育

戦後の障害児教育の歴史の大きな転換となったのが2007（平成19）年**特別支援教育**の開始です。これは、2006（平成18）年に「学校教育法等の一部を改正する法律」が公布され、翌2007（平成19）年に実施することを受けたものです。障害児教育にとっての大転換であったためこの年は「特別支援教育元年」とも呼ばれています。

特殊教育から特別支援教育への転換により、様々な点が変更されました。ここではそれらの内の（1）場による支援からニーズに応じた支援へ、（2）校内委員会と特別支援教育コーディネーターの設置、（3）特別支援学校の設置とセンター的機能の3点を説明します。

4.3.1 場による支援からニーズに応じた支援へ

従来の特殊教育と特別支援教育の最も大きな違いは、「**場による教育**から個々の児童生徒の**ニーズに応じた教育**」への転換だと言われます。従来の特殊教育は障害の種類や程度によって、教育を行う場を決めていました。例えば、「Aさんは重度の視覚障害があるので盲学校」や「Bさんは軽度の知的障害があるので中学校の養護学級」でといったように、障害種や障害の重さが教育を受ける場を決定していました。

このような場による教育には、障害種に応じたきめ細やかな指導ができるという点で一定の成果はあったもののいくつかの問題が生じていました。第1に、盲学校・聾学校、養護学校では、単一の障害を持っている幼児・児童・生徒のみならず、複数の障害がある重複障害の児童・生徒が在籍しており、単一の障害種に応じた支援方法では対応しきれないことがありました。

第2に、小・中学校の通常学級においても、LD・ADHD・高機能自閉症があり学習や生活の面で教育的支援を必要としている児童、生徒が一定数いることが調査で明らかとなり（以下のコラム参照）、そうした児童・生徒に対する支援を行う体制が十分でないことも問題でした。

これらの状況を踏まえて、障害児教育の体制は、特別な場で教育を行う特殊教育から、一人一人の教育的ニーズを把握して行う特別支援教育へと発展的に転換していきます。具体的には、従来、盲・聾・養護学校として障害種ごとの学校であったものを**特別支援学校**として障害種にとらわれない学校とすることや、小・中学校における特別支援教育の体制を整えること、特別支援教育を行う教員の専門性を担保するために、新たに特別支援学校教諭免許状を創設することとなりました。

💡 通常学級において特別な教育的支援が必要な児童・生徒

文部科学省が2002年に行った**実態調査**では、学級担任等を回答者にして通常の学級に在籍する児童生徒の学習面および行動面（不注意や多動、対人関係やこだわり）の困難について回答を求めました。その結果、小・中学校全体で、知的発達に遅れはないものの学習面や行動面で著しい困難を示すと担任教師が回答した児童生徒の割合が6.3%であり、通常の学級にも特別な支援が必要な児童、生徒数が一定数在籍していることが示されました。

この実態調査は**2012（平成24）年**および**2022（令和4）年**に継続して行われており、2012年では6.5%、2022年には8.8%でした。

この変化について宮本（2023）は、子どもたちを取り巻く環境の変化や不登校児の割合の増加とも関連づけて、数値の増加が持つ意味について論じており大変参考になります。

なお、これらの調査結果をもとに「発達障害がある児童生徒が〇〇%」のような報道がなされることもありますが、調査の留意次項として挙げられているように、発達障害の専門家による判断や医師による診断ではないので、この調査結果を「発達障害のある児童生徒数の割合を示すもの」として解釈することはできないので注意が必要です。

4.3.2 小・中学校における特別支援教育の推進

通常学級での特別支援教育を推進するために、校内支援体制の構築が欠かせません。特別支援教育では、特別な教育的ニーズを有する児童や生徒の対応を担当の教員一人に任せるのではなく、学校組織としてチームで支援をする体制作りを進めることとなりました。こうした体制において大きな役割を果たすのが、**個別の教育支援計画**および**個別の指導計画**の作成、**校内委員会**とそのキーパーソンである**特別支援教育コーディネーター**の指名です。

4.3.2.1 個別の教育支援計画と個別の指導計画

個別の教育支援計画は、児童・生徒の一人一人のニーズを把握して、乳幼児期から学校を卒業するまで一貫した教育支援をできるようにするために作成されるものです。例えば、幼稚園では十分な支援を受けていたにも拘らず、小学校においてその引き継ぎがなされずに一貫した支援を行うことができないといった事態を防ぐためにも、支援の指針となるものの作成が義務付けられました。また、この個別の教育支援計画の作成の際には、医療や福祉等の関係機関の関係者と情報を共有する際にも必要となります。

個別の指導計画は、児童・生徒の一人一人のニーズを把握した上で、一定期間の間に行う指導内容や支援の方法を具体的に示したものです。ここには指導目標やその達成基準等が示され、一定の期間後終了時にその達成状況を評価し、指導目標を設定したり、指導目標を達成できなかった場合には、支援の方略を見直したりすることで、PDCAのサイクル

に基づき、指導を行えるようにしています私が過去巡回に回っていた小学校や中学校では学期ごとに作成しているところが多かったです。

個別の教育支援計画は長期的な視点での支援について示したものである一方で、個別の指導計画は短期的な指導や支援の目的と方法を記したものと整理できます。

4.3.2.2 校内委員会と特別支援教育コーディネーター

校内委員会は、学校の校務分掌（役割分担）の一部として位置付けられるものです。ここでは、特別な教育的支援が必要な児童・生徒等を早期に発見し学級担任が当該の児童・生徒を支援することを助けたり、個別の指導計画や個別の教育支援計画の作成をする際に中心的な役割を果たしたりします。

こうした校内の体制整備においてキーパーソンとなるのが**特別支援教育コーディネーター**です。特別支援教育コーディネーターは校長が適任者を指名します。

特別支援教育コーディネーターの仕事は多岐に渡りますが、その中でも重要なものがチームによる支援を行うための連絡や調整係としての役割です。学校内においては、校内委員会開催のための情報収集や学級担任の支援、校内研修の企画等があります。また、校外の関係機関（医療、福祉、特別支援学校、教育委員会の専門家チーム等）との連絡の窓口となるほか、保護者の相談窓口となることもあります。

4.3.3 特別支援学校のセンター的機能

前項では小・中学校の特別支援教育の推進について触れましたが、特別支援教育では、特殊学級や特別支援学校などの特別な場だけでなく、通常学級を含む全ての学校において推進されるものとなりました。その際に、その実施をバックアップする役割が特別支援学校には求められるようになりました。その役割のことを、特別支援学校の**センター的機能**と呼びます。^{*6}。

センター的機能として特別支援学校に期待される役割として、2005年の中央教育審議会の「**特別支援教育を推進するための制度の在り方について（答申）**」では、以下の6つの内容例が示されています。

1. 小・中学校等の教員への支援機能
2. 特別支援教育等に関する相談・情報提供機能

^{*6} 学校教育法第74条においてセンター的機能は「特別支援学校においては、（中略）、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の要請に応じて、第八十一条第一項に規定する幼児、児童又は生徒の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとする」と規定されています。ここで「第八十一条第一項に規定する幼児、児童又は生徒」とは、「次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒」であり、次項各号として、知的障害者、肢体不自由者、身体虚弱者、弱視者、難聴者、その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なものが挙げられています。

3. 障害のある幼児児童生徒への指導・支援機能
4. 福祉、医療、労働などの関係機関等との連絡・調整機能
5. 小・中学校等の教員に対する研修協力機能
6. 障害のある幼児児童生徒への施設設備等の提供機能

「地域支援部」「相談部」「教育支援」等の名称でセンター的機能のための分掌が設けられることが多いと思います。地域の学校の教員や保護者からの相談を受けたり、教材や教具を公開したり、研修を開いたり地域の特別支援教育を底上げするための役割を果たしています。

4.4 特別支援学校の学習指導要領

学校教育では各学校ごとに、教育課程と呼ばれる学校の教育計画を立てて、教育の目的や目標を達成することを目指します。学校教育法では教育課程を編成する際の基準として**学習指導要領**を定めていて、おおよそ10年に一度改定をしています。

学習指導要領では、小学校、中学校、高等学校ごとに、教科の目標や教育内容を定めています。特別支援学校についても同様に学習指導要領が定められています。現在最も新しいものは小学校・中学校が2017（平成29）年に公示されたもの、高等学校が2019（平成31）年2月に公示されたものです^{*7}。

特別支援学校の学習指導要領は、幼稚部、小学部、中学部、高等部ごとに作成されます。ここでは、これらの全てを細かく見ることはしませんが、小学部と中学部を中心に特別支援学校の教育課程を特徴づける**自立活動**についてと、通常の学校等の目標とは別建てで示される、知的障害および重複障害の学習指導要領の特徴を確認します。

4.4.1 自立活動とは

通常の小学校や中学校において教育課程は、(1) 各教科、(2) 特別の教科 道徳、(3) 外国語活動（小学校のみ中学校では教科）、(4) 総合的な学習の時間、(5) 特別活動によって構成されます。特別支援学校の教育課程の編成ではこれらに加えて**自立活動**が含まれます。

2017（平成29）年4月に告示された学習指導要領では自立活動の目標を以下のように述べています。

個々の児童又は生徒が自立を目指し、障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培う（p.199）。

^{*7} 文部科学省の[ウェブサイト](#)で公開されています。

表 4.1: 自立活動の区分と項目（学習指導要領をもとに作成）

区分	項目
1. 健康の保持	(1) 生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。 (2) 病気の状態の理解と生活管理に関すること。 (3) 身体各部の状態の理解と養護に関すること。 (4) 障害の特性の理解と生活環境の調整に関すること。 (5) 健康状態の維持・改善に関すること。
2. 心理的な安定	(1) 情緒の安定に関すること。 (2) 状況の理解と変化への対応に関すること。 (3) 障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲に関すること。
3. 人間関係の形成	(1) 他者とのかかわりの基礎に関すること。 (2) 他者の意図や感情の理解に関すること。 (3) 自己の理解と行動の調整に関すること。 (4) 集団への参加の基礎に関すること。
4. 環境の把握	(1) 保有する感覚の活用に関すること。 (2) 感覚や認知の特性についての理解と対応に関すること。 (3) 感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。 (4) 感覚を総合的に活用した周囲の状況についての把握と状況に応じた行動に関すること。 (5) 認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること。
5. 身体の動き	(1) 姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。 (2) 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。 (3) 日常生活に必要な基本動作に関すること。 (4) 身体の移動能力に関すること。 (5) 作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること。
6. コミュニケーション	(1) コミュニケーションの基礎的能力に関すること。 (2) 言語の受容と表出に関すること。 (3) 言語の形成と活用に関すること。 (4) コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。 (5) 状況に応じたコミュニケーションに関すること。

自立活動の内容は、6 区分 27 項目にまとめられています（表 4.1）。この 6 区分 27 項目の内容を全て指導するわけでは**ありません**。個々の児童・生徒の自立を目指して、これらの中から必要な指導目標や指導内容を設定して、教育課程を編成します。したがって、A さんが行う自立活動の内容と B さんが行う自立活動の内容は異なったものとなります。

学習指導要領において、自立活動の内容を指導する場面については、「国語」や「算数」のような教科と同じように「自立活動の時間」を設定して指導を行うほか、各教科、道徳科、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動の指導の時間においても密接な関連を図って指導する必要があるとされています。

これについて理解するために以下のような例を考えてみましょう。知的障害があり自己の意思の表出を言葉で行うことが難しい児童が、絵カードを用いてコミュニケーションを図る内容を自立活動で学んでいたとしましょう。このとき、絵カードを使ったコミュニケーションが、設定された「自立活動の時間」のみで行われていたのでは、この自立活動の内容は、児童の学習上又は生活上の困難の改善には寄与しないでしょう。各教科の授業や特別活動においても絵カードを使ってコミュニケーションを使う練習の場とすることで、絵

カードを使ったコミュニケーションがその児童にとってコミュニケーションの手段として確立して、生活の質を高めることにつながっていくでしょう。

4.4.2 準ずる教育課程と知的障害及び重複障害のための教育課程

知的障害以外の障害のある児童・生徒に対する場合と、知的障害がある児童・生徒に対する場合とでは、各教科の扱いが大きく異なります。まず、特別支援学校全体についての教育課程について説明し、続いて知的障害がある場合について説明します。

4.4.2.1 知的障害がない場合の教育課程

特別支援学校小学部と中学部の学習指導要領の総則の p.61 では、教育課程の編成の際に以下の目標を達成することに努めるとされています。

1. 小学部においては、学校教育法第 30 条第 1 項に規定する小学校教育の目標
2. 中学部においては、学校教育法第 46 条に規定する中学校教育の目標
3. 小学部及び中学部を通じ、児童及び生徒の障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服し自立を図るために必要な知識、技能、態度及び習慣を養うこと

この 3 点目は、前項で説明した自立活動を指します。したがって、特別支援学校の小学部や中学部では、(通常の) 小学校教育の目標や(通常の) 中学校教育の目標を達成するための指導目標や指導内容を設定することとなりますが、これに加えて、障害における学習や生活上の困難を克服するための自立活動に基づき指導目標や指導内容を設定していくこととなります。

こうした教育過程編成は、**準ずる教育課程**とも呼ばれています。これは、学校教育法の第 72 条において、特別支援学校が施す教育が、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育と定められていることによります。

4.4.2.2 知的障害および重複障害がある場合の教育課程

知的障害がある児童生徒に対する教育では、知的障害の特徴により通常の小学校や中学校で示される各学年ごとの目標設定が児童生徒の実態に則さないケースがほとんどであるため、独自の教科の目標や内容が、学年ごとではなく段階ごとで示されています。これは知的発達の個人差が大きく、知的発達の個人差が大きく、学年による区分が意味をなさないためです。

具体的には、小学部では、生活、国語、算数、音楽、図画工作、体育の 6 教科が 3 段階で示されます。外国語活動は必要に応じて設けることができる教科として扱われます。中学部においては、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、職業家庭の 8 教科が 2 段階で示されます。

知的障害がある児童生徒を対象とする特別支援学校では、これらの学習指導要領を基準としながら、子どもの実態に応じて指導目標と内容が個々に設定されます。このとき、各学部ごとに示される段階というのもあくまで目安であり、知的な障害が重い中学部の生徒は小学校の段階の学習を行っていることもあります。

また、知的障害がある児童生徒の特別支援学校では、各教科を別々に指導するのではなく、**教科等を合わせた指導**も行われています。これは、知的障害がある児童生徒の場合、教科別で学んだ知識は断片化して実生活に活かせないことが多いからで、実際の生活の場に応じた実践的な知識として教科内容を教えるためには、教科ごとに分けないで指導を行った方が効果的だという考えからきています。典型的な各教科を合わせた指導としては、日常生活の指導、遊びの指導、生活単元学習、作業学習などがあります。

学習指導要領で示される各教科等の内容は、教育内容に基づく分類なのに対して、実際の指導の場ではその分類とは異なった形態で指導が行われることとなります。この状態を指して、知的障害の教育課程は**二重構造**だと言われることもあります。

4.4.3 重複障害者等に関する教育課程の取扱い

重複障害がある場合には障害の状態像が多様であるため、必要がある場合にはさらに弾力的に教育課程を編成することができます。具体的には、各教科、道徳科、外国語活動、特別活動の目標および内容に関する事項の一部や、各教科、外国語活動、総合的な学習の時間の代わりに、自立活動を主とした指導で教育課程を編成することができます。

4.5 補足

4.5.1 自立活動について参考資料（★）

自立活動の指導目標や指導内容を設定する際のポイントについて、教育委員会等が資料を提供しています。具体的なイメージが湧きづらい場合には参照してみると良いでしょう。

- 島根県教育委員会 [授業づくり（自立活動）](#)
- 岡山県総合教育センター [自立活動ハンドブック－知的障害のある児童生徒の指導のために－ ver.2](#)

4.5.2 特別支援教育への転換期の重要文書（★）

2007（平成 19）年の特別支援教育の開始に関係する通知や報告書へのリンクをまとめてあります。

- 2001（平成 13）年 1 月 調査研究協力者会議 [21 世紀の特殊教育の在り方について（最終報告）](#)

- 2003（平成 15）年 3 月 調査研究協力者会議 [今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）](#)：「特別支援教育」の名称が文部科学省の公的な文書で初めて用いられた
- 2005（平成 17）年 12 月 中央教育審議会 [特別支援教育を推進するための制度の在り方について（答申）](#)：盲・聾・養護学校の特別支援学校への一本化，小・中学校における支援制度の見直し，特別支援学校教員免許状
- 2006（平成 18）年 3 月 学校教育法施行規則の一部改正（[通知](#)）※ [PDF](#)：通級の対象に学習障害者と注意欠如多動性障害者を加え，情緒障害から自閉症者を独立
- 2006（平成 18）年 6 月 特別支援教育の推進のための学校教育法等の一部改正（[通知](#)）：特別支援教育へ転換するための法改正。施行は 2007（平成 19）年 4 月 1 日から。

第5章

インクルーシブ教育と近年の動向

5.1 インクルーシブ教育とは

英語の inclusive には「包括的な」「だれでも参加できる」といった意味があります。インクルーシブ教育（inclusive education）とは、「だれもが参加できる教育」だと言えます。ここではインクルーシブ教育について説明した後に、現在の日本の特別支援教育の現状と近年の動向を検討します。

5.1.1 サラマンカ声明

インクルーシブ教育が多くの人に認知されるきっかけとなったのは、1994年にユネスコとスペイン政府が共催した「特別なニーズ教育に関する会議：アクセスと質」において採択された**サラマンカ声明**です*1。

この声明では、障害がある人を含めた全ての人の教育を受ける権利を保障する「**万人のための教育**（Education for All）」の目的を達成するために、「特別ニーズ教育に関する行動の枠組み」が承認したと述べられています。声明の目的に関する説明に続き、万人のための教育を達成するためのインクルーシブ志向の学校について次のような宣言がなされます*2。

- すべての子どもは誰であれ、教育を受ける基本的権利をもち、また、受容できる学習レベルに到達し、かつ維持する機会が与えられなければならない、
- すべての子どもは、ユニークな特性、関心、能力および学習のニーズをもっており、

*1 声明の正規名称は「特別なニーズ教育における原則、政策、実践に関するサラマンカ声明ならびに行動の枠組み（Salamanca Statement on principles, Policy and Practice in Special Needs Education and a Framework for Action）」です。サラマンカはスペインの都市の名前で旧市街地が世界遺産に登録されているそうです。

*2 この翻訳は中野（1997）のものを引用しました。

- 教育システムはきわめて多様なこうした特性やニーズを考慮にいれて計画・立案され、教育計画が実施されなければならない、
- 特別な教育的ニーズをもつ子どもたちは、彼らのニーズに合致できる児童中心の教育学の枠内で調整する、通常の学校にアクセスしなければならない^{*3}、
- このインクルーシブ志向をもつ通常の学校こそ、差別的態度と戦い、すべての人を喜んで受け入れる地域社会をつくり上げ、インクルーシブ社会を築き上げ、万人のための教育を達成する最も効果的な手段であり、さらにそれらは、大多数の子どもたちに効果的な教育を提供し、全教育システムの効率を高め、ついには費用対効果の高いものとする。

この声明は、「万人のための教育」が目的だと述べられているように、障害児への教育のみを対象としたものではありません。児童労働や貧困、戦争や武力紛争の犠牲者など教育を受ける権利が保障されていない子ども全てを対象としているものです。

これに続いて、政府への要求として「個人差もしくは個別の困難さがあるとうと、すべての子どもたちを含めることを可能にするよう教育システムを改善することに、高度の政治的・予算的優先性を与えること」等を求めています。

インクルーシブ教育は一人一人は違うことを前提に、そうした子どもたちの教育を受ける権利を保障できる体制づくりを求めていると言えます。

5.1.2 インクルージョンのためのガイドライン

ユネスコが2005年に発表した「[インクルージョンのためのガイドライン \(Guidelines for Inclusion : Ensuring Access to Education for All\)](#)」もインクルーシブ教育を理解するのに役立ちます。副題には「万人のための教育」が含まれていることに注目してください。

このガイドラインではまず、インクルージョンの起源が特殊教育にあることを紹介しつつ、現在ではその実践は「インテグレーション (integration)」として知られるアプローチを通じて、障害のある子どもを通教学級に統合するメインストリーミング (mainstreaming) へとシフトしていることに触れています。続けて、障害がある子どもを通常学級に参加させる際に障壁となる要因として、通常学級や学校組織が障害がある児童のための変更や調整を行わないことに言及した後に、障害のある子どもが経験する困難は、現在の学校がそうした子どもたちの多様性を受け入れるように組織されていないこと、および、教授法に柔軟性がないことに起因すると分析しています^{*4}。

^{*3} 「彼らのニーズに合致できる児童中心の教育学の枠内で調整する、通常の学校」と訳されている箇所の原文は “regular schools which should accommodate them within a childcentered pedagogy capable of meeting these needs” です。ここでの pedagogy は「教育学」というよりは、「教授法」の意味合いで捉えた方が分かりやすいように思います。ユネスコが出している[ブックレット※PDF](#)を読んでも、ここで書かれていることのイメージが湧くかもしれません。

^{*4} 障害の原因を社会のシステム側に求めるこの発想は第2.1.1項で紹介した社会モデル的な考え方ですね。

続けて、多様性に対応できるような通常の学校へと改革を進めていくことが必要であると述べられます。子どもたち一人一人の違いは、「解決すべき問題 (problems to be fixed)」としてではなく、「学習を豊かにする機会 (opportunities for enriching learning)」として捉えるべきだと、発想の転換をすることが求められます。

ガイドラインでは、インクルージョンの重要な要素として次の4つを挙げています (p.15)。

1. インクルージョンはプロセスである。(Inclusion is a process.)
2. インクルージョンは障壁の特定と除去に関係する。(Inclusion is concerned with the identification and removal of barriers.)
3. インクルージョンとは、すべての生徒が「教育の場に」いること、参加、達成についてである。(Inclusion is about the presence, participation and achievement of all students.)
4. インクルージョンは、社会から疎外されたり、排除されたり、学業不振に陥ったりする危険性のある学習者グループに特に重点を置く。(Inclusion involves a particular emphasis on those groups of learners who may be at risk of marginalization, exclusion or underachievement.)

この3番目について補足します。いること (“presence”) とは、「どこで教育を受け、どれだけ確実に、時間通りに通うか」についてであると説明されているので、名簿上いるだけでなく実際に教育が行われる場に他の生徒と同じぐらいの時間出席することが重視されていることを意味します。続く「参加」(participation) は、そこでの経験の質に関係すると説明されます。例えば、出席はしているものの、内容を何も理解できずにいるだけでは意味がないということです。最後の「達成」(achievement) は、単なるテストの結果にとどまらない、カリキュラムを通じて得た学習の成果についてということです。つまり、実際に教育の場において、有意義な学習の経験を積み、カリキュラムが目標とするものを実際に身につけることが必要というわけです。

例えば、重度の知的障害がある人を通常学級が行われている場にただ連れてきて、教員の言うことが何も理解できていなくとも授業時間が終わるまでいれば良い、というのはインクルージョンになりません。

ガイドラインが求めている4つの要素を満たすためには、教授法やカリキュラムに柔軟性が必要になるため**通常学校の改革**が求められる訳です。

このガイドラインを元にして野口(2022)はインクルーシブ教育を以下のように定義しています。インクルーシブ教育のポイントを明確に示してあるので紹介しておきます。

i インクルーシブ教育の定義

インクルーシブ教育は、多様な子どもたちがいることを前提とし、その多様な子どもたち（排除されやすい子どもたちを含む）の教育を受ける権利を地域の学校で保証するために、教育システムそのものを改革していくプロセス

ここでは、定義中のいくつかポイントを解説してみます。

まず、定義の中で「多様な子どもたち（排除されやすい子どもたちを含む）の教育を受ける権利」という言葉に注目しましょう。インクルーシブ教育は多様な子どもたちの**教育を受ける権利**を保障するためのものです。教育を受ける権利は基本的人権に含まれるもので、誰もが持っているものです。

なぜこのようなことを明言する必要があるかという点、障害児を含む多様な子どもたちは現行の教育システムから排除されやすいからに他なりません。例えば、自閉スペクトラム症がある人は一般に聴覚的情報よりも視覚的情報の処理を得意としていて、指示が口頭のみで出される場合には活動にうまく参加できないことが多々あります。しかしながら、学校では指示が口頭のみで出されることが少なくありません。このような場合には、自閉スペクトラム症の人は活動にうまく参加できずに教育を受ける権利が十分に保証されているとはいえないでしょう。

もう一つ注目してほしいポイントは「教育システムそのものを改革していくプロセス」という箇所です。全ての子どもたちの教育の権利を保障する過程ではうまくいった取り組みもあればうまくいかない取り組みもあるはずで、その中では教育内容やその指導の方略を見直して変更・修正していく必要が常にあります。多様なニーズを持つ子どもたちの権利を保障するという理念に基づき、絶えず良い方法を模索し続けるその過程こそがインクルーシブ教育だということです。

5.1.3 障害者の権利に関する条約との関連

ここでは第2.3節で解説した障害者権利条約の中で、教育がどのように扱われているかを見てみましょう。障害者権利条約では、教育について第24条で以下のように定めています（以下は外務省の訳）。

締約国は、教育についての障害者の権利を認める。締約国は、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、障害者を包容するあらゆる段階の教育制度及び生涯学習を確保する。当該教育制度及び生涯学習は、次のことを目的とする。(a) 人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達させ、並びに人権、基本的自由及び人間の多様性の尊重を強化すること。(b) 障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること。(c) 障害者が自由な社会に効果的に参加することを

可能とすること。

ここで「障害者を包容するあらゆる段階の教育制度」はもとの英語では”an inclusive education system at all level”です。インクルーシブ教育の推進は、障害者の教育の権利を保障するものとして条約に定められています^{*5}。

障害者権利条約の第 24 条では、この目的を達成するために条約締結国に次の 5 つを求めています。

1. 障害者が障害に基づいて一般的な教育制度から排除されないこと及び障害のある児童が障害に基づいて無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から排除されないこと。
2. 障害者が、他の者との平等を基礎として、自己の生活する地域社会において、障害者を包容し、質が高く、かつ、無償の初等教育を享受することができること及び中等教育を享受することができること。
3. 個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。
4. 障害者が、その効果的な教育を容易にするために必要な支援を一般的な教育制度の下で受けること。
5. 学問的及び社会的な発達を最大にする環境において、完全な包容という目標に合致する効果的で個別化された支援措置がとられること。

この条約の批准を受けて 2012 年の中央教育審議会の「[共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）](#)（以下、中教審報告）」は、インクルーシブ教育を実現するための日本の特別支援教育の方向性を示しました。

中教審報告の中では、**連続性のある「多様な学びの場」**を整備していくことが重要であると述べられています。学ぶ場のオプションを増やすことで、多様なニーズに対応する方略をとっていると言えます。

インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要である。小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意しておくことが必要である。

また、これらそれぞれの指導の場において、適切な環境整備を進めていくことに加えて、各地域で学校間の連携を充実させていくことの重要性を指摘しています。例えば、特別支援学校教員の巡回相談（センター的機能の一つ、第 4.3 節参照）であったり、地域のバランスを考慮して特別支援学校の分校・分教室を設置することであったり、特別支援の教育

^{*5} 文部科学省の文書にしばしば出てくる「インクルーシブ教育システム」とはこれのことです。

資源が偏らないようにすることが必要だと述べられています。

💡 一般的な教育制度と特別支援学校

中教審報告において、障害者権利条約中にある「一般的な教育制度（the general education system）」に特別支援学校が含まれるかが検討されました。これは特別支援学校が一般的な教育制度に含まれないのであれば、特別支援学校は障害のある幼児児童生徒を一般的な教育制度から排除していることになるため、日本の特別支援教育はインクルーシブ教育に逆行することになります。

中教審報告の中では、外務省に照会が行われ「条約第24条に規定する「general education system（教育制度一般）」の内容については、各国の教育行政により提供される公教育であること、また、特別支援学校等での教育も含まれるとの認識が条約の交渉過程において共有されていると理解している。したがって、「general education system」には特別支援学校が含まれると解される」という回答が[参考資料](#)として提出されています。

こうした背景もあり、多様な学びの場全体を持って一般的な教育制度とするという（日本独特の）解釈で、特別支援学校や特別支援学級等の特別な支援の場を整備する方向に日本の特別支援教育は進んでいます。ただ、この方向性が正しいのかについては、次節の近年の動向や2022年9月の障害者権利委員会による総括所見等も含めて再検討する必要があると感じます。

5.2 近年の動向

ここでは今後の特別支援教育やインクルーシブ教育のあり方を考えます。まず、特別支援教育を受ける児童生徒数の推移について確認します。続けて、障害者権利委員会による対日本審査の初回報告の教育の箇所について検討します。この総括所見を、より理解するためにはその半年ほど前に物議を醸した文部科学省による通知についても知っておくと良いので、それについても合わせて解説します。

5.2.1 特別支援教育を受ける児童生徒数の増加

5.2.1.1 文部科学省の調査結果

特別支援学校に在籍する幼児児童生徒の推移を図5.1に示しました。子どもの数は減っているにも拘らず、2007年の特別支援教育スタートから一貫して増え続けていることが分かります。この増加は全ての障害種で均等に起こっている訳ではなく、知的障害者の幼児児童生徒が増えたことによって全体が増えています。

続いて特別支援学級に在籍する児童生徒の推移を図5.2に示しました。ここでも特別支援学校と同様に、在籍する児童生徒の数が増えていることが分かります。知的障害と自閉

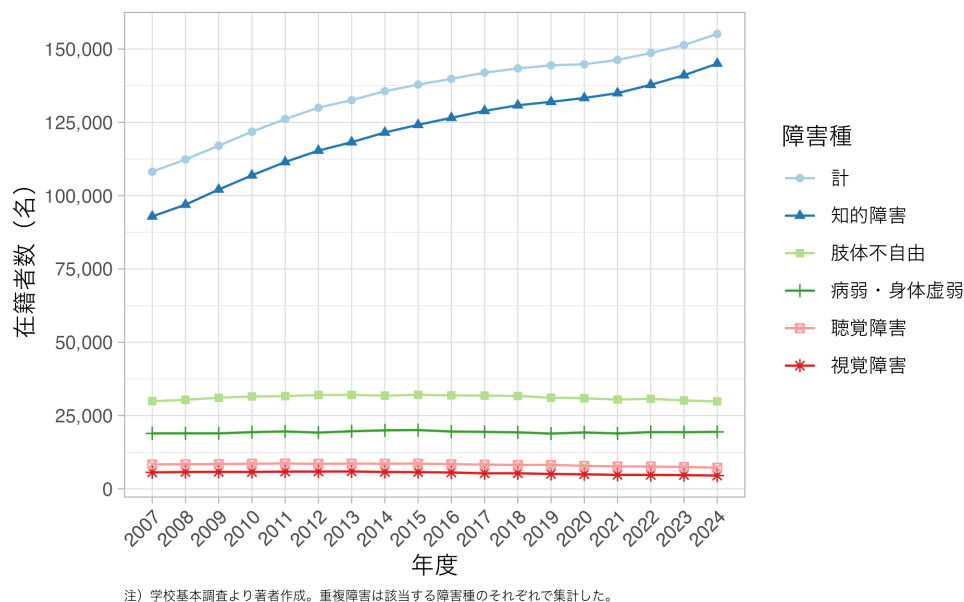


図 5.1: 特別支援学校の幼児児童生徒数の推移

症・情緒学級で特に増えていることが分かります。

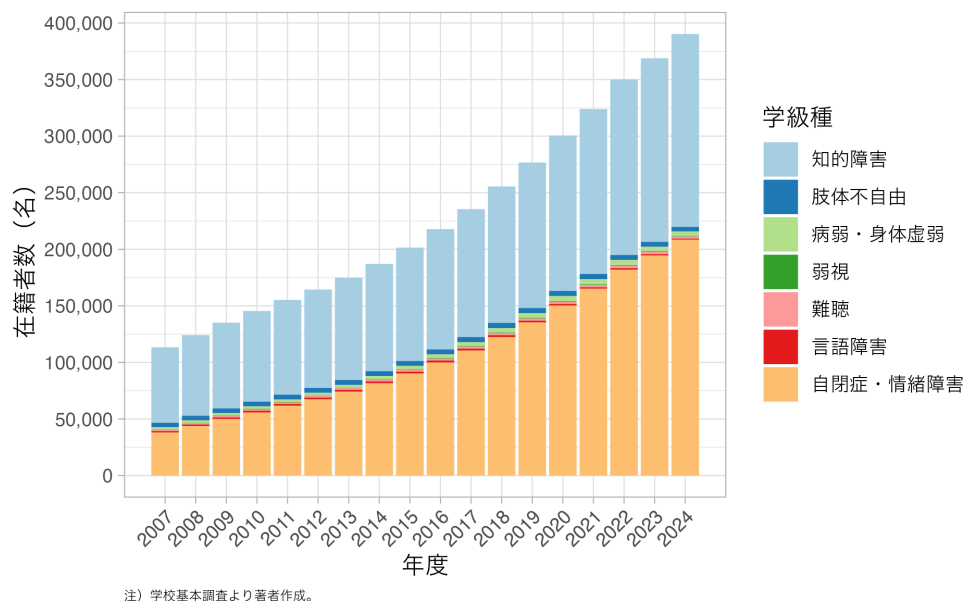


図 5.2: 特別支援学級の児童生徒数の推移

通級による指導を受けている児童生徒数について、学習障害や注意欠陥多動性症候群を対象に含めた 2006 年分からの推移を図 5.3 に示しました。注意欠陥多動性障害、学習障害、自閉症、情緒障害において特に増加しており、2006 年度に比べて 2022 年度は全体で 4 倍

以上の数の児童生徒が通級による指導を受けるようになりました。

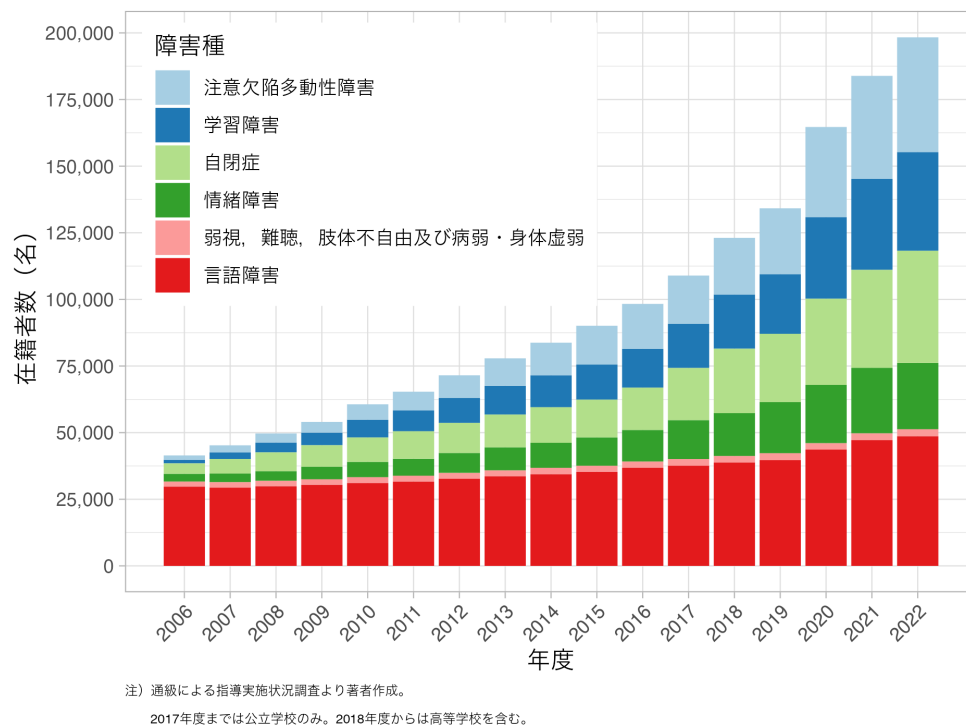


図 5.3: 通級による指導を受けているの児童生徒数の推移

5.2.1.2 増加の原因

特別支援教育を受ける幼児・児童・生徒数の増加については様々な原因が考えられています。増加の理由の一つとして、特別支援教育に関する理解や認識が高まってきたことを文部科学省は挙げています^{*6}。従来は特別支援学校や特別支援学級の取り組みは知られていなかったものの、近年では、学級あたりの児童生徒数が少ない特別支援学校や特別支援学級では通常学級に比べてきめ細やかな個別支援を受けやすいことが知られるようになり、従来はそうした場を選ばなかった人が選ぶようになって在籍の児童生徒が増えたという説明です。

ただし、この説明を疑問視する声もあります。菅原（2022）は、日本において特別支援学校・学級を選択する児童生徒が増え続けている現状が十分に検証されていないことを問題視しており、「友達や先生に負担をかけるかもしれない」「学校にエレベーターがないから」といった消去法や諦めから特別支援学校や学級を選択している可能性について言及しています。国際的なインクルーシブ教育の流れには逆行していることを指摘した上で、特別支援学校・学級の増加傾向に合わせて教室数を増やす方向が本当に良いものかについて

^{*6} 朝日新聞、2022年3月2日朝刊

再考を求めています。

通常学級における「許容度」の低下が特別支援学校や特別支援学級の在籍者数の増加に寄与しているという考えもあります。楠見（2024）は、現在の日本の教育システムが標準的とされる子ども像を基準に設計されており、その標準的な教育課程に適応できない子どもが特別な配慮や支援を与えられようになっていることを指摘した上で、特別支援学校や特別支援学級の在籍者数の増加していることは通常教育の許容度の低下を反映していると分析しています。

特別支援学校の在籍者数や通級による指導を受ける児童生徒の増加は、教室などの学校設備の不足や指導する教員の不足といった問題も引き起こしています。文部科学省が2023年の10月に行った調査では、全国の公立特別支援学校で3359教室が不足していることが明らかとなっています^{*7}。

この増加の原因を分析した上で、必要な体制を整えていくことは今後の課題と言えるでしょう。

5.2.2 障害者権利条約の対日審査

近年の動向で最も重要なものの一つが障害者権利条約対日審査の総括所見です。第2.3節で説明したように、障害者権利条約の締結国における実施状況をモニタリングするための審査の仕組みがあります。その初回審査の総括所見が、2022年の9月に障害者権利委員会から公表され、その中でさまざまな領域にわたって93の懸念と92の勧告が出されました。特に教育に関する24条については障害者権利委員会は強く注意を喚起しました。

ここでは、第24条の教育についての箇所を確認します。懸念事項の中で2022年4月に文部科学省が出した通知について触れられているので、最初にその内容を確認した後に、総括所見の内容を検討します。

5.2.2.1 2022（令和4）年4月の文部科学省通知

文部科学省は2022（令和4）年の4月27日に「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について」という通知^{*8}を出しました。通知では、2021（令和3年）に行った調査の結果から特別支援学級在籍児が通常学級で学ぶ時間が多い学校があることを問題視した上で、都道府県や市町村の教育委員会に対して特別支援学級に在籍する子どもは目安として週の半分以上は支援学級で過ごす（つまり、通常学級で授業を受ける時間は週の半分より少なくする）ように求めました。

^{*7} 文部科学省の2024年3月26日報道発表「公立特別支援学校における教室不足調査の結果について」。この発表によれば、教室不足数は2013（平成25）年から2019（令和元）年までは減ってきていましたが、それ以降は増えたり減ったりをしています。対応として文部科学省は国庫補助制度等を用いて支援学校の設置者（都道府県や市区）の教室不足対応への取り組みを優先的に補助しています。

^{*8} 日付をとって「4.27通知」と呼ぶ人もいます。

この通知は、先進的なインクルーシブ教育を実践している大阪府に特に影響を与えました。大阪府では、従来から知的障害がある子どもが通常学級でなるべく多くの授業を受けられるように、特別支援学級の担任が通常学級での授業をサポートする形で共に学ぶ体制を整えてきました^{*9}。しかし、この通知に従うと、特別支援学級に在籍したまま通常学級の授業を受ける時間を制限せざるを得なくなります。特別支援学級から通常学級に転籍することでこの制約はなくなりますが、特別支援学級の担任教員のサポートは無くなってしまうので通常学級での学習への参加が難しくなるケースが出てきます。

この通知を受けて、大阪府内のいくつかの自治体では支援教育の方針転換が進めらるようになりました（大久保，2024）。具体的には、通知が出た2022年度から2023年度にかけて全国的には特別支援学級の在籍者数が増加しているのにも拘らず、大阪府の公立小中学校では支援学級の児童生徒数が減少しました。その一方で、大阪府の公立小中学校の通級による指導を受ける児童生徒の数は急増しており、通知の影響が障害児の学ぶ場へと影響を与えたのではないかと考えられています。

この通知が障害がある児童生徒が障害のない児童生徒と共に学ぶ権利を侵害していると、大阪府枚方市と東大阪市の6名の児童と保護者は、2022年10月に大阪府弁護士会に救済を申し立てました。大阪弁護士会は調査を行い、2024年3月には「子どもたちがインクルーシブ教育を受ける権利を侵害している」として、通知の授業時間に関する部分の撤回を国に勧告しています。なお、文部科学省は通知は「インクルーシブ教育を目指したものだ」と反論して、通知の撤回には応じないこととしています。

5.2.2.2 総括所見の教育（第24条）に関する箇所

それでは障害者権利委員会による総括所見の教育に関する箇所を確認してみましょう。障害者権利委員会が示した懸念事項は6点あります。

- (a) 医療に基づく評価を通じて、障害のある児童への分離された特別教育が継続していること。障害のある児童、特に知的障害、精神障害、又はより多くの支援を必要とする児童を、通常環境での教育を利用しにくくしていること。また、通常の学校に特別支援学級があること。
- (b) 障害のある児童を受け入れるには準備不足であるとの認識や実際に準備不足であることを理由に、障害のある児童が通常の学校への入学を拒否されること。また、特別学級の児童が授業時間の半分以上を通常の学級で過ごしてはならないとした、2022年に発出された政府の通知。
- (c) 障害のある生徒に対する合理的配慮の提供が不十分であること。

^{*9} 日本の一部地域においては国際的なインクルーシブ教育の動向とは別に、障害児も健常児も通常学校の通常学級の中で共に学ぶ運動が行われていました。大阪はこうした運動が盛んな地域の一つです。こうした地域における教育実践は、1994年のサラマンカ声明よりもずっと前から存在した日本流のインクルーシブ教育実践だと考えることができます。日本におけるこうした運動については二見（2017）や久米（2022）を参照してください。

- (d) 通常教育の教員の障害者を包容する教育（インクルーシブ教育）に関する技術の欠如及び否定的な態度。
- (e) 聾（ろう）児童に対する手話教育，盲聾（ろう）児童に対する障害者を包容する教育（インクルーシブ教育）を含め，通常の学校における，代替的及び補助的な意思疎通の様式及び手段の欠如。
- (f) 大学入学試験及び学習過程を含めた，高等教育における障害のある学生の障壁を扱った，国の包括的政策の欠如。

(a) を読むと分かるように，特別支援学校や特別支援学級のように異なる場で特別な教育を行うことについては，分離された特別教育（segregated special education）と評価がなされています。また，(b) では，前項でとりあげた 2022 年 4 月の文部科学省の通知も懸念事項として扱われています。その他の項目を見てもインクルーシブ教育への体制転換の不十分さを指摘する内容です。これらの 6 つの懸念に対応する形で，国に対しては次の 6 点の要請が出されました。

- (a) 国の教育政策，法律及び行政上の取り決めの中で，分離特別教育を終わらせることを目的として，障害のある児童が障害者を包容する教育（インクルーシブ教育）を受ける権利があることを認識すること。また，特定の目標，期間及び十分な予算を伴い，全ての障害のある生徒にあらゆる教育段階において必要とされる合理的配慮及び個別の支援が提供されることを確保するために，質の高い障害者を包容する教育（インクルーシブ教育）に関する国家の行動計画を採択すること。
- (b) 全ての障害のある児童に対して通常の学校を利用する機会を確保すること。また，通常の学校が障害のある生徒に対しての通学拒否が認められないことを確保するための「非拒否」条項及び政策を策定すること，及び特別学級に関する政府の通知を撤回すること。
- (c) 全ての障害のある児童に対して，個別的教育要件を満たし，障害者を包容する教育（インクルーシブ教育）を確保するために合理的配慮を保障すること。
- (d) 通常教育の教員及び教員以外の教職員に，障害者を包容する教育（インクルーシブ教育）に関する研修を確保し，障害の人権モデルに関する意識を向上させること。
- (e) 点字，「イージーリード」，聾（ろう）児童のための手話教育等，通常教育環境における補助的及び代替的な意思疎通様式及び手段の利用を保障し，障害者を包容する教育（インクルーシブ教育）環境における聾（ろう）文化を推進し，盲聾（ろう）児童が，かかる教育を利用する機会を確保すること。
- (f) 大学入学試験及び学習過程を含め，高等教育における障害のある学生の障壁を扱った国の包括的政策を策定すること。

この勧告に対する対応を尋ねられた当時の文部科学大臣は，特別支援学校や特別支援学級等の多様な学びの場で行われている特別支援教育を中止することは考えていないとコメン

トを述べています^{*10}。

5.3 補足

5.3.1 ウェブ上で見ることができる映像等（★）

インクルーシブについて考えるためにウェブ上で見ることができる資料を紹介します。

- [Educating Peter](#)

1992年のアカデミー章短編ドキュメンタリー映画賞を受賞した作品です。ダウン症がある小学校3年生ピーターが通常学級に転籍した1年のドキュメンタリー映像です。最初は教室の中で問題を起こしていたピーターが適用して徐々に周りの児童たちを変えていった様子が描かれています。

障害がない子どもとある子どもが一緒に学ぶインクルーシブ教育のポジティブな面を象徴的に描く一方で、サクセスストーリーとして描きすぎている、成功のために必要とされる人的な支援や環境的な支援について描かれていない等の批判もあったようです（水内，2023, p. 59）。

※ 設定ボタンから自動翻訳機能をつかって日本語字幕をつけることもできます。

^{*10} 永岡桂子文部科学大臣記者会見録（2022（令和4）年9月13日）

第6章

関係機関との連携

特別支援教育では、障害児の教育において多様な立場の専門職と協働する必要があります。ここでは、特別支援教育における他職種連携の基本的な考え方と、連携の代表的なものです医療的ケア児や放課後等デイサービスとの連携を説明します。

6.1 個別の教育支援計画と他（多）職種連携

個別の教育支援計画は第4.3節で紹介したように、特殊教育から特別支援教育への転換期に作成が求められるようになった学校における支援計画です。個別の教育支援計画の作成の目的として以下のように書かれています^{*1}。

「個別の教育支援計画」は、障害のある児童生徒の一人一人のニーズを正確に把握し、教育の視点から適切に対応していくという考えの下、長期的な視点で乳幼児期から学校卒業後までを通じて一貫して的確な教育的支援を行うことを目的とする。また、この教育的支援は、教育のみならず、福祉、医療、労働等の様々な側面からの取組が必要であり、関係機関、関係部局の密接な連携協力を確保することが不可欠である。他分野で同様の視点から個別の支援計画が作成される場合は、教育的支援を行うに当たり同計画を活用することを含め教育と他分野との一体となった対応が確保されることが重要である。

それぞれの障害児の必要な支援ニーズは異なっていますが、そのニーズを満たすために教育領域以外において、取り組みが求められる際には連携をしていく必要が述べられています。その際に、障害児の支援において、だれ（どの機関）がどのような役割を果たすかを明確にする必要があります^{*2}。

^{*1} 今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）参考資料

^{*2} 各自治体がフォーマットを公開しているので見てみると具体的なイメージが付きやすいかもしれません。
例えば、愛知県における小・中学校の「個別の教育支援計画」は次のページで見ることができます。

6.2 医療との連携

6.2.1 医療機関との連携

特別支援学校に通う子どもたちの中には、医療によるサポートを必要としている子どもたちが多数います。医療が教育に提供できることとできないことを把握しておくこと、医療との適切な連携のあり方を考えることができます。

小野（2012）では、発達障害を念頭に医療が教育に提供できるものとして「診断」「投薬」「保護者への専門的説明」等が挙げられています。

日本においては、障害の診断は医師のみが行える行為です。問診や検査等で情報を集め、診断基準に合致しているかを見極めた上で、慎重に行われます。診断を行うことにより、行政のサポート等周囲の支援を受けやすくなったりするメリットがあります。例えば、公共料金等が割引になったり、障害者向けの様々なサービスを利用する際に必要な障害者手帳の取得はそうしたものの一つでしょう。

2つの国際的な診断基準：ICF と DSM

工事中

日本においては、処方箋を書いて投薬の指示を出すことは医師のみが行えます。慢性的な疾患の関係で様々な薬の服用が必要なこともあれば、注意欠陥多動性症候群の子どもに対して行動調整を助けるための薬が出されることもあります。学校や家庭において適切な環境を整えてもなお行動の調整に困難がある場合にはこうした連携が非常に重要です。

子どもの障害について、保護者に対して説明も医師が行います。専門性がある教員が障害の大まかな特性について保護者に説明することもあります。医療機関で医師から専門的な説明が提供されることの方が一般的です。

逆に医療が教育に提供できないこととして、小野（2012）は、日々の生活におけるきめ細やかな支援体制を挙げています。医学的な診断を受けることはその人が支援を受けやすくなりますが、診断がついたからといって生活が直接的に改善される訳ではありません。診断の情報を活かした上で、障害児一人一人にあった適切な支援のあり方が提供されなければ、効果的な連携にはならないでしょう^{*3}。

^{*3} 市河 他（2024）は教員を対象「教育と医療の連携」について行なった調査を報告しています。疾患としては、神経発達症（発達障害）などの精神・行動の異常に関するものと、医療的ケア児について連携が多くなされていることが示されています。しかしながら、「連携が十分に機能している」と感じている教員は少なく、より適切な連携のあり方を模索していく必要がありそうです。

6.2.2 医療的ケアとは

医療の進歩とともに、ICU（新生児集中治療室）で命が助かる子どもたちが増えた一方で、NICUでの長期入院後の生活の中で**医療的ケア**を日常的に必要とする児童・生徒等（医療的ケア児）の数が年々増加しています。2021（令和3）年6月に成立した「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（医療的ケア児支援法）」では医療的ケアを「人工呼吸器による呼吸管理、喀痰（かくたん）吸引その他の医療行為」と定義しています。

病気治療のための入院や通院とは異なり、医療機関以外の場所で行われるこうした医療的ケアの担い手は従来家族でした。その結果、家族が医療的ケアのために学校に付き添わなくてはならず家族の離職を招くという問題がありました。医療的ケア児とその家族を支援することは2016年の児童福祉法の改正で各省庁および地方自治体の努力義務とされていましたが、支援体制はまだ十分ではありませんでした。

こうしたことを背景に2021年に成立した医療的ケア児支援法では、医療的ケア児とその家族の支援を国や地方公共団体の責務として定めました。保育所等や各種学校等が医療的ケア児を受け入れることの支援を義務付けたのです。小学校、中学校、高等学校や特別支援学校においては、家族の付き添いがなくとも医療的ケア児の受け入れが可能となるように、看護師等の配置を行うようになっています。

6.2.3 特別支援学校の教員による医療的ケア

医療的ケアは原則として、学校に配置された看護師（や准看護師）が行います。2012（平成24）年の社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正によって、一定の研修を修了すれば、一定の条件の下で特定の医療的ケアについては教員でも実施できるようになりました。ただし、このような場合においても、看護師等を中心に連携教職をした上で十分な安全を確保する必要があります。

医行為と特定行為

「当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為」のことを**医行為**と呼びます。日本では医師法によって医師、歯科医師、看護師等の免許を持っていない人が医行為を継続して行なってはいけないことと決まっています。

2012（平成24）年の制度改正では「口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養」の5つの行為に限って、看護師等の免許を持たなくとも、研修を修了して認定された者（認定特定行為業務従事者）にかぎって一定の条件下で実施できるようになりました。この5つの医行為は**特定行為**と呼ばれます。この5つ以外の医行為については、

学校で看護師等が実施することになります。

6.3 福祉との連携

障害児の支援では、福祉サービスとの連携も必要となります。障害者が使う福祉サービスについては、18歳までは「児童福祉法」の下で実施される事業において、18歳以上では「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（通称、障害者総合支援法）」の下で実施される事業において行われています。ここでは、特別支援学校と関係の深い放課後等デイサービスについて説明します。

6.3.1 放課後等デイサービス

放課後等デイサービス^{*4}とは、小学校に入学する6歳から18歳までの障害児を対象としたサービスです。児童福祉法では、放課後等デイサービス以下のように定義されています。

この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法（中略）に規定する学校（幼稚園及び大学を除く。）又は専修学校等（中略）に就学している障害児（中略）につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう（第6条の2の2第3項）

特別支援学校で放課後等デイサービスを利用する児童生徒は、授業終了後にデイサービスのスタッフが学校まで送迎に来て、放課後等デイサービスの事業所まで移動して夕方までの時間を過ごすことが多いです。

子ども家庭庁による[放課後等デイサービスガイドライン](#)では、放課後等デイサービスの基本的な役割を4つに分類しています。第1の役割が、障害児に対する「本人支援」です。障害児の支援のニーズを踏まえた上で、日常生活を充実させたり自立を支援するための活動、多様な遊びや体験活動、地域交流の活動、こどもが主体的に参画できる活動を提供して、子どもの育ちを促すことを目的としています。

第2の役割が、「家族支援」です。障害がある子どもと家族が安定した関係を継続できるように支援をしたり、子育てに関する困りごとの相談にのったりすることが期待されています。ガイドラインの中では、家族支援を家族が子どもの障害の特性を理解するための重要な支援と位置付けていますが、家族が子どもの障害特性等を理解していくプロセスは多様であり、家族ごとに異なっていることにも触れており、慎重に行うことについて触れています。

^{*4} 略して「放デイ」と呼ばれることが多いです。

第3の役割が、「移行支援」です。インクルージョンの考え方にもとづき、地域において行われている多様な学習・体験・活動に参加できるように支援を行うことが求められています。必要に応じて放課後等児童クラブ（いわゆる学童）等との連携をとりながら、移行を支援したり、平行利用を促進したりすることが求められています。

第4の役割が、「地域支援・地域連携」です。保健・医療・福祉・教育・労働等の関係期間と連携して障害児本人やその家族の支援を行うことが求められています。

事業所とのケース会議

特別支援学校と放課後等デイサービスで支援の方向性を揃えるために、在籍する学校の担当教員と放課後等デイサービスの担当者が集まって情報を共有する**ケース会議**を持つこともあります。学校と事業所で状態像が異なる場合には、児童・生徒の過ごす環境が異なっていることも多いので、こういった環境（支援）がある場合に、どのような行動が見られるのか、普段から記録をとっておくことが重要です。なお、こういった連携の取り組みに熱心な事業所もあればそうでない事業所もあり、事業所ごとの特色があります。

第 7 章

障害者と成人期

7.1 特別支援学校卒業後の進路

ここでは、特別支援学校の高等部を卒業した後の進路について紹介します。障害の種類や程度によって、また、個人の違いによって、進路は大きく異なりますが、進学、就労、その他の場合で分けて考えてみましょう。

7.1.1 高等教育機関への進学

障害者の権利に関する条約の第 24 条の 5 において、「締約国は、障害者が、差別なしに、かつ、他の者との平等を基礎として、一般的な高等教育、職業訓練、成人教育及び生涯学習を享受することができることを確保する。このため、締約国は、合理的配慮が障害者に提供されることを確保する。」と述べられています。障害がない人と同じように高等教育等の機会均等が求められています。

また、2021（令和 3）年に改正され、2024（令和 6）年に施行された障害者差別解消法では、国や地方公共団体のみならず、一般の事業者においても合理的配慮の提供が法的義務となりました。これにより、国公立の大学等のみならず私立大学でも合理的配慮の提供が義務付けられました。

日本学生支援機構が実施している「[障害のある学生の修学支援に関する実態調査](#)」によれば、2023（令和 5）年度に大学、短期大学、高等専門学校に在籍する障害学生数は 58,141 人（全体の学生数の 1.79%）でした。調査を開始した 2005（平成 18）年度では学生数は 4,937 人（全学生に対して 0.16%）でしたので、20 年弱で障害学生数は 10 倍以上になっています。

小中学校や特別支援学校における障害児の支援体制に比べると、高等教育機関における支援体制の整備は遅れているのが現状です。日本学生支援機構が、障害学生の支援や配慮の事例を紹介していたり、一般社団法人「全国高等教育障害支援協議会」が中心的な役割と

なって、高等教育における障害支援のネットワークができています。また、各大学等でも障害学生支援の部署が作られるなど取り組みが進んでいますが、大学等によって取り組みはまばらです。

7.1.2 企業への就職

障害者が就職する場合に重要になってくるのが、日本における障害者雇用の仕組みです。

7.1.2.1 日本の障害者雇用の制度

日本では「障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）」が障害者の職業的自立を促進するための措置を定めています。その中で、国や地方公共団体、民間企業に対して、障害者を一定の割合で雇うことを義務付けています。この割合は**法定雇用率**と呼ばれています。

法改正により、2024（令和6）年4月からは、従業員40人以上の事業主では従業員数のうち2.5%、2026年7月からは、従業員37.5人以上の事業主は、従業員数のうち2.7%の障害者を雇うことを義務付けています。なお、法定雇用率の対象となる人は障害者手帳を所持している人です。例えば、雇用している労働者が150人いる場合だと、2024年4月からは3人以上（ $150 \times 2.5\% = 3.75$ 人、小数点切り捨て）の雇用の義務があり、2026年7月からは4人以上（ $150 \times 2.7\% = 4.05$ 人、小数点切り捨て）の雇用の義務があります。

法定雇用率を達成できなかった場合には、ハローワークが雇用率達成指導という行政指導を行うこととなっています。この指導では、雇入れ計画を作成するように命令があり、その計画がうまく行かない場合にはさらなる指導が行われ、状況によっては企業名の公表が行われます。

💡 特例子会社

工事中

7.1.3 福祉サービスの利用

進学や就労をしない場合には、社会福祉施設等に入所や通所することになります。個人ごとの支援ニーズによって、本人にあう進路を選ぶこととなります。障害者総合支援法に基づく社会福祉施設には、以下のようなものがあります。

- 就労移行支援事業
- 就労継続支援事業（A型）※ 雇用契約を結ぶ
- 就労継続支援事業（B型）※ 雇用契約を結ばない
- 生活介護事業所

7.2 成人期の生活とライフスキル

成人期の生活は、仕事だけではありません。日々の生活は様々な活動から成り立っています。こうした活動において必要とされるスキルは**ライフスキル**と呼ばれています。

7.2.1 ライフスキルとは

ライフスキルという用語は World Health Organization (1996) の報告書の中で次のように定義されています。

ライフスキルとは、個人が適応的で建設的な行動を行うための能力である。それらの行動により個人は、日常生活において要求や課題に効果的に対処できるようになる。(拙訳、原文は、Life skills are abilities for adaptive and positive behaviour, that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life.)

この定義に従って考えると、ライフスキルは無数のものを含むことになりますし、また、文化やその人が置かれる環境によってライフスキルは異なることになります。そこで、報告書の中ではそれらの中からコアとなるスキルセットを以下のように 10 項目特定しています (pp. 1-2)。

- 意思決定：自分の生活に関する決定を助けるスキル
- 問題解決：生活において生じる問題に建設的に対処することを可能とするスキル
- 創造的思考：意思決定や問題解決の際に可能な代替案を検討することを可能とするスキル
- 批判的思考：情報や経験を客観的に分析するスキル
- 効果的コミュニケーション：文化や状況に適切な形で、言語および非言語の両方を用いて自分自身のことを表現するためのスキル
- 対人関係：関わる人々と肯定的な関係を持つことを助けるスキル
- 自己認識：自分自身に関すること、自身の性格、自身の強みや弱み、自身の好き嫌い等を認識するスキル
- 共感：自分自身が慣れ親しんでいない状況であっても、他者にとって生活がどのようなものかを想像することを可能とするスキル：
- 感情のコーピング：自分自身および他者の感情を認識し、感情が行動にどう影響を与えるかを意識し、感情に対して適切に対応することを可能とするスキル
- ストレスのコーピング：私たちの生活の中にあるストレスの原因を認識し、それがどのように私たちに影響を与えるかを理解し、ストレスのレベルをコントロールする助けとなる行動をとるスキル

これらのスキルを身につけることで成人期の生活は豊かになるでしょう。この報告書で取り上げられているライフスキルは障害児に向けたものという訳ではないので、スキルによっては習得が難しいものも含まれています。

こうしたことを背景に梅永（2014）は、成人が生活する中で日常的に行なっている様々な活動をライフスキルとして定義して、それらを早期から指導していくことの重要性を指摘しています。どのようなスキルが含まれるかを整理する際の視点として、1日、1週間、1ヶ月などの単位で区切って、その地域での生活の行動を列挙しています。例えば、働いている成人の平日1日の活動として以下のような活動が挙げられています（梅永，2014，p. 80）。

- 朝決まった時間に自分で起きる
- 起きたら顔を荒らす
- 朝食をとる（自炊の場合は調理や食器洗い）
- 歯を磨く
- （男性の場合）髭を剃る
- （女性の場合）化粧をする
- 髪をセットする
- 適切な服に着替える（靴、靴下も含む）
- 家に鍵をかける
- 乗り物を利用する（車の場合は運転する）
- 遅刻をせずに職場に行く
- （職場によっては）タイムカードを押す
- （場合によっては）てきどな職場の衣服（制服や作業着）に着替える
- 上司、同僚に「おはようございます」の挨拶をする
- （午前中の仕事を終わると）昼食をとる
- お昼休みに適切な余暇（コーヒーを飲む、雑誌を読むなど）をとる
- 仕事が終わった後にタイムカードを押す
- ときに応じて残業をする
- （職場によっては）職場の服から自分の服に着替える
- 仕事が終わった後に上司や同僚に「失礼します」の挨拶をする
- スーパーやコンビニで買い物をする
- ATMを利用する
- 帰宅すると手を洗う
- 夕食をとる（自炊の場合は料理をし、食器を洗う）
- 入浴する（洗髪も含む）
- パジャマなどの部屋着に着替える
- テレビを見たりCDを聴いたり（ゲームや読書）余暇を楽しむ
- 寝る前に歯を磨く
- 適切な時間に就寝する

同様に、1 週間の場合の活動（休日の余暇の過ごし方や、爪切り等が含まれる）や、1 ヶ月の活動（散髪や公共料金の支払い等が含まれる）を考えることができます。こうした活動をリストアップすることで、成人生活で必要とされるスキルの具体的な内容を特定することができます。

ハードスキルとソフトスキル

職業リハビリテーションにおいて、機械の操作やタイピングなどの仕事そのものに関わる能力は**ハードスキル**と呼ばれています。一方で、対人的な行動やコミュニケーション、など就労生活に間接的に関係するスキルは**ソフトスキル**と呼ばれます。梅永（2017）は自閉スペクトラム症の成人の就労上の課題や離職理由を整理する中で、ハードスキルよりもソフトスキルの不足による離職が多いこと指摘しています。そして、ソフトスキルのベースには日常生活のスキル（ライフスキル）があり、そうしたスキルを十分に獲得することを支援することが、障害者が成人期に幸せに生きることにつながるとして、早期からのライフスキル教育の重要性を述べています。

7.2.2 特別支援学校におけるキャリア教育

特別支援学校の学習指導要領では段階に応じてキャリア教育について触れられています。小学部・中学部の学習指導要領では、キャリア教育の充実について以下のように述べられています。

児童又は生徒が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう、特別活動を要としつつ各教科等の特質に応じて、キャリア教育の充実を図ること。その中で、中学部においては、生徒が自らの生き方を考え主体的に進路を選択することができるよう、学校の教育活動全体を通じ、組織的かつ計画的な進路指導を行うこと。（第 5 節 1 の（3）、p.71）

この箇所について学習指導要領の解説では、キャリア教育は学校の教育活動全体を通じて図っていく重要性を指摘しつつも、それらの中でも特別活動の学級活動をキャリア教育の要として位置付けている点に注意しています。

高等部段階においては、小学部・中学部のねらいに加えて、進路指導の際には「家庭及び地域や福祉、労働等の業務を行う関係機関との連携を十分に図ること」の必要性が述べられています。さらに、キャリア教育及び職業教育に関して配慮すべき事項として、体験的な学習指導の必要性を指摘しており、長期間の実習等の就業体験活動の機会を設けることが示されています。

 高等特別支援学校

知的障害の特別支援学校の中には、知的障害の程度が軽度である生徒を対象に企業就労を目指した学びをおこなう「高等特別支援学校」が全国的に増えてきています。こうした学校は企業への就職率も高いので入学希望者が年々増えており、入学試験の選抜も厳しいものとなる傾向があるようです。高等特別支援学校では、企業と提携して実際の就労現場で求められる技能ができるようなカリキュラムが組まれることが多いです。

例えば名古屋市だと、2024（令和6）年に「[名古屋市立若宮高等特別支援学校](#)」が新たに開校しました。複数の提携企業と一緒にこなっています。

第8章

保護者やきょうだいへの支援

障害児教育において障害児の家族との連携はかせません。ここでは保護者および障害児のきょうだいをとりあげ、その支援について解説します。

8.1 保護者との連携

保護者は障害児の支援のキーパーソンです。第2.2説の国際生活機能分類（ICF）の箇所を確認したように、障害者の生活機能や障害の状況はその人を取りまく環境因子によって大きく左右されます。障害児のサポートを考える上で保護者との連携はかせません。

本節では、まず保護者との連携がなぜ必要なのかについて考えます。続いて、保護者は支援者であると同時に保護者も支援を必要としているという認識の上で、どのような支援が必要かを考えます。

8.1.1 保護者との連携の必要性

保護者と効果的に連携することは、障害がある子どもの育ちを支える環境を構築する上で必須です。障害児本人についておよび家庭の環境についての情報を共有することで障害児一人一人に合った支援を行うことができます。

8.1.1.1 情報共有

障害がある子どもの適切なサポートをするためには、その子どもについてよく知る必要があります。多くの場合において、障害児について最もよく知っているのは保護者です。保護者から得た情報を整理した上で、その情報を生かした支援を行うことで、効果的な支援が可能になります。

保護者と情報を共有する際には、子どもが日常生活の中で支援を必要とする事柄ととも

に、それがどのような環境下で生じているのかを共有するようにします。また、困りごとだけでなく、その子どもの好みや得意なことも合わせて聞くようにすると、その子どもの強みを生かした支援につながります。

場面や環境によって見られる行動に違いがある場合には子どものことをよりよく理解するチャンスです。例えば、問題となる行動が学校では見られるのに家庭では見られないといった場合には、2つの場面で異なっているものが何なのかを特定することによって、どのような環境要因が問題行動を引き起こしているかを探ることができます。

i コラム：共同治療者としての保護者

アメリカのノースカロライナ州で行われている自閉症支援のプログラムであるTEACCHプログラムでは、親を共同療育者（co-therapist）として位置付けています。その根底には、保護者は子どものことをよく知っており、プログラムのスタッフは自閉症そのものについて理解と経験があるため、両者が協力することにより大きな成果を挙げられるとの考え方があります（佐々木，2008）。

特別支援教育においては、教員が持っている障害児における教育についての理解と経験を保護者が持っている子どもの理解と組み合わせることでより良い支援体制を築くことができると期待されます。

8.1.1.2 共通の支援の方向性の統一

家庭と学校では環境が違うので、日常生活のためのサポートの細かな方法が異なることはよくありますが、大きな方向性は揃えられると良いでしょう。例えば、知的障害のある子どもが家庭ではスケジュールを理解するために絵カードを使っているのに、学校では言葉のみでスケジュールを伝えるようにしていたら、子どもは大きく混乱することでしょう。こうしたときに、学校や家庭で同じように絵カードを使ってスケジュールを伝えるようにすることは、子どもの混乱を少なくして取り組むことができる活動を増やすとともに、絵カードスケジュールの使い方というスキルを異なる場面で使えるようにする機会^{*1}にもなりますので

家庭においてどのようなコミュニケーションが伝わりやすいのかについて情報を得ることで学校でも同じ方向性の支援ができます。逆に、学校でうまくいったコミュニケーションの方法を家庭に伝えることで、家庭での困りごとが解決することもあります。

8.1.2 支援対象としての保護者

保護者は障害児の支援者であると同時に、保護者自身も支援を必要としていることが多いです。保護者と関わる際には、保護者が支援者であると同時に被支援者でもあるというこ

^{*1} なお、特定の場面で得たスキルを他の場面で使えるようになることは**般化**と呼ばれています。

とを意識して関わる必要があるでしょう。

実際に障害がある子どもの親はメンタルヘルスの問題を抱えやすいことが様々な調査から明らかになっています。例えば、Chen et al. (2023) が行ったオーストラリアにおける調査では、障害がある子どもの親は障害がない子どもの親に比べてメンタルヘルスの問題を生じやすかったことが報告されています。年齢や性別などのデモグラフィック変数や就業状況等の社会経済的変数を統制した結果、障害がある子どもの親は障害のない子どもの親に比べて平均して 2.1 倍ほどメンタルヘルスの問題が生じやすいと推定されています。日本においても、Yamaoka et al. (2015) によれば、障害がある子どもの親のおおよそ半分 (44.4%) が心理的苦痛を感じており、8.9 については深刻な精神の疾患があることが報告されています。

したがって、保護者と関わる際には保護者自身がサポートを必要としているという視点を持って連携をしていかなければなりません。では、保護者はどのようなサポートを必要としているのでしょうか。必要とするサポートは家族をとりまく状況やライフステージによって当然異なります。井上 (2015) では発達障害の子どもを持つ親の相談・支援ニーズを幼児期、児童期、青年期、成人期と区切って整理しています。以下では、井上 (2015) で紹介される幼児期および児童期の支援の例を紹介します。

8.1.2.1 幼児期の支援

幼児期では、(1) 気づき段階の支援、(2) 診断前後の支援、(3) 支援や相談に関する情報提供、(4) 障害特性の理解に基づいた具体的な支援、(5) 就学に対する相談支援、が具体例として挙げられます。

幼稚園や保育園で集団生活を経験するようになると、周囲の子どもと自分の子どもを比較する機会が増えます。こうした機会に、集団になじめなかったり、他の子どもができるのに自分の子どもができないことを意識するようになり、発達の遅れや偏りに気づくようになります。この段階や診断前後の段階では、親は葛藤や不安、ストレスを抱えることが知られています。こうした段階では、親の日々の苦労を共感的に受け止め親の気持ちに寄り添う支援を行いながら共通理解を図っていく態度が求められます (具体的な面接の技術については井上 他 (2019) も参考にしてください)。

子どもの診断後には、地域の療育機関に関する情報提供であったり、子どもの障害特性についての理解を促したりしつつ、食事や着替えといった日々の生活の困りごとを軽減する工夫を一緒に考えていきます。地域によっては、ペアレント・トレーニング等の親支援のためのプログラムが活用できることもあるので、親を支援するためのネットワークに関する情報を持っておき、親のニーズに応じて適宜情報を提供できることが肝心です。

8.1.2.2 児童期の支援

発達障害児の児童期に必要な支援としては、(6) 親やきょうだいとの関係や問題行動についての相談・支援、(7) 学習や学校適応に関する相談、(8) 教師や学校に関する相談、(9) 友人関係に関する相談、(10) いじめ・不登校などいわゆる二次的な問題に関する予防と治療、(11) 投薬に対する理解や相談が挙げられています。学校生活を中心とした児童の適応状況に対する支援を中心に、医療機関等との連携もしつつニーズを満たす必要があるでしょう。

学校での適応の状況が悪いと、障害がある子どもたちの行動上の問題や不登校等の問題につながるため、保護者と教師の密接な協力関係が必要になります。家庭と学校では様子が異なるケースも多々あるので、共通の理解にたった上で子供が必要としている支援を特定し、

障害がある子どもの保護者はしばしば、子どものできないところを指摘される経験が多くなりやすいです。子どもができないことばかりを話題にするのではなく、子どもができるようになったことに注目しながら、どのような環境下で子どもが成功体験を積みやすいのかを保護者と共有して、子どもの成長と一緒に楽しめるような関係を構築することが望ましいでしょう。

8.1.3 「障害受容」という言葉について

障害者を支援する立場にある人の中においても、親の障害受容は話題に挙がる場合があります。望ましいことではないですが、これらの場面において「自身（家族）の障害を受け入れることができない当事者」を指して、その当事者は「自身（家族）の障害受容ができていない」というような批判のトーンを含んで使われることがあります。

こうした「障害受容」の使われ方に対して、田島（2015）は障害を負った当事者や家族が障害を受容する過程は個人ごとに千差万別で、行ったり来たりの過程であり、そうした個人差を理解しないで障害受容の過程を一律に障害者に押し付けることの問題を指摘しています。そして専門家や支援者に対して、次の4つの提言をしています。

1. 完全に「障害受容」することなどできない。
2. 専門家・支援者は「障害受容」は対象者に絶対に押し付けるな！
3. 専門家・支援者は「障害受容」を求めるのではなく、サービスの選択肢の少なさや障害に対する負の烙印を問題視すべきである。
4. 「障害受容できていない」と思わせる人は「孤立した状態にいる」と捉え、行為レベルで一歩踏み出し、その人にとって希望の感じられる仲間（もちろん自分であってもよい）やその人にとっての目の前の課題をクリアできる支援につながるよう働きかけよう。

8.2 きょうだいの支援

障害児・者と暮らす兄弟姉妹のことをきょうだい児と呼びます。彼らは様々な悩みがあり、障害児と同様にサポートをしている必要があります。

8.2.1 きょうだいをめぐる諸問題

障害児のきょうだいは様々な心理社会的な問題に直面します（柳澤，2007）。その一つが孤独感や罪悪感です。一般に、障害児を持つ親は障害児の世話をする時間が多くなりがちです。これによって、きょうだいが孤独感を抱いたり、親の愛情をめぐり、障害児と張り合うことになり、そのことに罪悪感を抱いたりするようです。

その他に、障害児のケアや家事の負担が増えることにより、自分の時間を持てなくなることも挙げられます。これは、きょうだいの社会性や情緒の発達に影響を及ぼすことにつながります。

8.2.2 きょうだい児への支援

きょうだい支援には様々なものがあります。そうしたものの一つが、きょうだい児同士の出会いや交流の場を提供することです。米国きょうだい支援プロジェクト（The Sibling Support Project）が開発したシブショップ（sibshop、シブリング（きょうだい）のためのワークショップを意味する造語）は特に有名です。シブショップは現在ではアメリカだけでなく世界中で行われています。日本においての実施状況は[きょうだい支援を広める会](#)のウェブページで紹介されています。

またシブショップ以外にも各国で様々なきょうだい支援の取り組みがなされており、[日本きょうだい福祉協会](#)のウェブページで紹介されています。

8.3 補足

8.3.1 保護者の障害の受け止め方のモデル（★）

子どもが障害を持って生まれた場合に、家族がどのような反応をするかについてはいくつかのモデルが考案されています。しかし第 8.1.3 項の障害受容の箇所でも述べたように、障害の受け止め方は家族によって多様であるため、モデルによって捉えることには限界があります。ここでは桑田・神尾（2004）を参考にして、そのいくつかを紹介しますが、モデルを無理に当てはめて考えるのではなく、あくまで参考として捉えるようにすると良いでしょう。

親が子どもの障害を受け止めていく過程に関する理論は大きく分けると、**段階説**（stage theory）と**慢性的悲嘆説**（chronic sorrow theory）に大別できます。前者は、親の障害受容は段階を経て進むとする説なのに対して、後者は子どもの変化や生活上のさまざまな出来事によって繰り返されるとする説です。

段階説では、モデルによって段階の数や段階の名称は異なるものの、第一段階では障害の診断が下されて障害の告知を受けたことから始まり、最終段階では子どもに障害があることのへの適応や受容がなされるという点で共通しています。日本ではドローター（Drotar）らによる5段階のモデルがよく紹介されます（Drotar et al., 1975）。ドローターは、先天性奇形を持つ母親20名と父親5名に対してインタビューを行い、障害児の親の心理的な変容について、①ショック、②否認、③悲しみ・怒り・不安、④適応、⑤再起という順番で障害受容が進むと考えました。

慢性的悲嘆説によるモデルで最も有名なものは、オルシャンスキ（Olshansky）によるモデルです。慢性的悲嘆とは、親が子どもの障害を知った後に、絶え間なく悲しみ続ける状態を指します。専門家は、親が慢性的な悲哀に苦しんでいることに気づかず、親に悲嘆を乗り越えるように励ましており、自然な感情である悲哀を表明することを妨げていると指摘しています。

また、障害受容を段階としてとらえず、かつ慢性的な悲哀やジレンマが異常な反応ではなく通常の反応であるという理解を促すモデルとして中田（1995）は障害受容の螺旋形モデルを提案しています。このモデルは、親の内面には障害を肯定する気持ちと否定する気持ちが裏表の関係にありながら常に存在することを仮定しています。表面的にはふたつの感情は交互に現れ、落胆と適応を繰り返しますが、それらは段階ではなく連続した過程であり、すべてが適応の過程である点に特徴があります。

8.3.2 特別支援学校における連携の実際（★）

特別支援学校は、通常の小中学校に比べて、個別の面談、家庭訪問、連絡帳、送迎時の会話など、保護者とやりとりの機会が多いです。

その中でも連絡帳は特別支援学校では、家庭であったことと学校であったことを手軽に共有できるツールとして多くの学校で使われています。子どもの様子がいつもと違うことが家庭や学校での特定のイベントによって引き起こされていることはよくありますので、日々変化する子どもの様子を理解するのに非常に役立ちます。

第9章

障害者と決定

私たちは日常生活で様々なことを自分で決めて暮らしています。例えば、今日の夕飯を何にするか、今度の休日にどこに行こうかといったこともそうですし、進学のタイミングでどの学校に行こうか、あるいは、就職のタイミングでどの企業や業界に就職しようかといった大きな決断もあるでしょう。こうした決定の場面において、人に相談することもあります。最終的には自分のことは自分で決めるというのが一般的です。

今回は障害者が自分のことを自分で決めるということについて考えてみましょう。

9.1 障害者の意思決定

9.1.1 法律行為と法律能力

私たちは自分の意思に基づいて様々な行いをしていますが、その行いによって様々な権利や義務が生じます。例えば、コンビニで飲み物を買おうと思ったときに、レジまで商品を持っていきその飲み物を欲しいことを伝え（て、店側が売ることを了承す）ると売買契約が成立します。売買契約が成立したことにより、売主である店は飲み物を引き渡す義務（目的物引渡義務）が発生します。同時に、買主はその対価として、代金支払いの義務が生じます。

今の例で見た売買契約のように、意思の表示によって法律上の効果を発生させる行いを**法律行為**と呼びます。法律行為には様々なものがあり、例えば大学や職場の近くのアパートの賃貸借契約も法律行為です。

法律行為の大原則は、当事者間の意思の表明に基づいて権利や義務が発生するものであるということです。その性質から、当該の行為によってどのような権利や義務が発生するかを理解していないままに法律行為が行われると問題が生じるため、民法では制限行為能力者制度を定めて判断能力がないものを保護しています。具体的には未成年者と成年被後制度の開始を受けたものが制限行為能力者と定められており（民法 20 条）、単独で有効な

法律行為を行うことができず、法定代理人等が代わって行為を行うか同意が必要だとされます。なお、単独で有効に法律行為を行える能力のことを行為能力と呼び、法律行為による権利の取得や義務を負うことができる権利能力と合わせて**法律能力**と呼びます。

成年後見制度

知的障害、精神障害、認知症などがあると不動産や預貯金の管理や身のまわりの世話のための介護サービスの契約などの法律行為を一人で行うことが難しい場合があります。時には不利益な契約をよく分からないままに結んでしまうことがあります。ひとりで決めることが難しいそのような人々を法的に保護するために2000年に始まった制度を、**成年後見（せいねんこうけん）制度**と言います。家庭裁判所が成年後見人等を選任する法定後見制度と、ひとりで決められる内にあらかじめ後見人等を決めておく任意後見制度の2つに分かれます。

法定後見制度では、対象となる人の障害や認知症の程度によって「補助」「補佐」「後見」と3つの類型があり、後者ほど後見人等が同意したり取り消したりすることができる法律行為が多くなります。成年後見制度は見方を変えれば、行為能力が不十分である知的障害者たちの意思決定を制限する側面があるため、障害者の意思決定について考える場合にしばしば話題に上がります。

9.1.2 障害者権利条約における法的能力

障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）の第12条は、障害者の法律能力について扱っています^{*1}。その第2項では「締約国は、障害者が生活のあらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を享有することを認める」としています。

このようにわざわざ書かれるのは、成年後見制度のように障害者の法的能力はしばしば制限されることがあり、障害者の自己決定の権利が侵害されることにつながるケースがあるからです。例えば、日本において成年被後見人である脳性マヒ者が施設での生活を終えて出身地近くで一人暮らしを始めようとしたところ、成年後見人であった実の弟が拒み続けて、スムーズに自立生活に進めなかったという事例が報告されています（崔，2024）。

また、2003年の国連総会の国連事務総長報告では、成年後見制度が知的障害や精神障害がある人から法的能力を剥奪するために不適切に用いられることが頻繁にあり、自分の人生について重要かつ基本的な決定をする権利が奪われていることを指摘しています（United Nation, 2003）。

成年後見制度は障害があって意思決定が困難な人を保護する制度として一定の役割を果たしているものの、成年後見によって自分自身で決める権利が制約される可能性もあるた

^{*1} 以下の権利条約の法的能力の記述は池原（2010）を参考にしました。より詳細に知りたい場合にはそちらを参照してください。

め、そうした権利をどのように守っていくかについての議論も生じさせています。障害者権利条約はこうした背景のもとで成立したものです。

9.1.3 代行決定から支援を受けた自己決定へ

障害者権利条約は障害者が行う諸々の自己決定について、パラダイムの変換を締結国に求めています。池原（2010）によれば、障害者権利条約の審議過程で障害者の自己決定をどのように支えるかについての議論が行われ、障害者のために他人が本人に代わって決定する**代行決定**から、障害者本人が支援を受けながら自己決定をする**支援を受けた自己決定**（Supported decision making）を目指すようになりました。

障害者権利条約の第12条の第3項には「締約国は、障害者がその法的能力の行使に当たって必要とする支援を利用する機会を提供するための適当な措置をとる」とされていますが、これは意思決定の捉え方の変容を反映しています。すなわち、意思決定はあくまで障害のある人の主体的な決定を前提としており、そのために必要な支援はあっても良いということです。ただし、障害のある人が主体的な決定を行うことができないとする前提に立つ代行決定とは異なる自己決定のあり方を目指すべきだとされています。

意思決定をするにあたり必要な支援の程度は異なります。障害の程度が重く意思決定をするにあたって、ほとんど100%の支援が必要なケースもあり、こうなると代行決定とあまり変わらなくなってきます。こうしたときに、障害者の権利が不当に侵害されないように、乱用を防止する必要があります。その内容を定めたのが第4項です。

4. 締約国は、法的能力の行使に関連する全ての措置において、濫用を防止するための適当かつ効果的な保障を国際人権法に従って定めることを確保する。当該保障は、法的能力の行使に関連する措置が、障害者の権利、意思及び選好を尊重すること、利益相反を生じさせず、及び不当な影響を及ぼさないこと、障害者の状況に応じ、かつ、適合すること、可能な限り短い期間に適用されること並びに権限のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関による定期的な審査の対象となることを確保するものとする。当該保障は、当該措置が障害者の権利及び利益に及ぼす影響の程度に応じたものとする。

9.1.4 意思決定とコミュニケーションの支援

特別支援教育の対象となる幼児児童生徒は未成年であり一人で有効な法律行為を行う能力はないため、これまでの話は教育とは関係が薄いように感じられるかもしれません。しかし、大人になったときに自分らしい生き方を障害者本人が自分で決定していくためには学齢期からの準備が重要でしょう。自分のことを決めるというのは成人したら（18歳になったら）急にできるようになるものではありません。それまでに自分のことを決める十分な経験の積み重ねと練習が必要です。

自分自身のことについて意思決定ができるようになるためには様々な要因が関わってくると思いますが、ここではコミュニケーションの面から意思決定を支える支援を考えてみましょう。コミュニケーションには理解と表出の側面があります。

9.1.4.1 理解コミュニケーション

私たちが何かしらについて意思決定をする際には、決めるための判断材料が必要です。例えば、選挙で誰に投票するかを決める際にはそれぞれの立候補者がどのような主張をしているかを知った上で投票する人を決めたいと思うでしょう。立候補者の主張というのは、街頭演説や新聞へのインタビューで伝達されますが、そういった情報が障害がある人にとってアクセスしやすいものであるかは分かりません。

障害がある人が何かを決めることに困難がある場合には、決めるための材料をその人が持っているのかを考える必要があります。言い換えると、決定するための情報は保証されているのかを確認する必要があるということです。知的障害があっても抽象的な言葉での理解が困難な場合には、伝えるための言葉を選ぶ必要もあるでしょう。[一般社団法人スローコミュニケーション](#)では、知的障害がある人に理解しやすい形で情報提供を行なっているので、ページを訪れていくつかニュース記事を見てみると良いでしょう。

障害がある人に必要な情報が正しく伝わるのが意思決定の基盤となりますので、障害がある人に伝わりやすいコミュニケーションの方法を確立し、また、その情報を引き継ぎ情報保障していくことが学齢期では重要な支援だと言えるでしょう。

9.1.4.2 表出コミュニケーション

決めるための判断材料がそろって自分の意思を決めたとしても、それを他者に伝えないと生活の場に意思が反映されません。意思を表出するための手段が必要になります。

私たちの社会では、口頭で自分の意思を表出することに困難がない人が大多数なのでコミュニケーションというと口頭のものを想像しがちですが、意思伝達においては口頭のコミュニケーションに制限する必要はありません。筆記や絵カードや具体物等、障害がある人にとって使いやすいコミュニケーションの手段が確立できることが重要です。そうした自分にとって使いやすい手段を用いて「自意見を表出した結果、相手に伝わった」という経験を重ねることが意思決定を行うための基盤となります。

こうして考えたときに、日常生活の多くの場面が意思決定とそのコミュニケーションの練習の機会と捉えることができるでしょう。重度の知的障害がある生徒で日常生活のほぼ全ての場面で介助が必要な例で考えてみます。日常生活の場面を切り取ってみても、学校のどの洋服を着ていくか、給食のおかずをどれから食べるか（どれを食べないか）、体育の授業のために校庭まで移動するときのどのルートを通っていくか、など生活の中には様々な選択の機会があります。

こうした機会を本人が決定をするための練習の場として考えてみると良いでしょう。重い障害があっても口頭でのコミュニケーションでは十分に意思が確認できないことがあるかもしれません。そうした場合には、写真や絵カードを使ったり、具体物を使ったり、その人にとって伝わりやすい手段で選択をすることが重要でしょう。また、たくさんの可能性があっても選べない場合には、最初は2つから選ぶなど選択肢を限定する必要があるかもしれませんが、選択になれてくるとより多くの選択肢があっても選べるようになることも多いです。

教育現場において様々な理由^{*2}から支援者が先回りして選んで支援を行う場面をよく見ますが、「本人の意思決定をサポートするためにどのような支援が必要か」という視点を持って、日々の関わりを見直せると良いでしょう。

^{*2} 本人が決めるよりも支援者にとって「効率の良い」やり方になっていることもあれば、そうするのが絶対に本人のためだと思っている（思い込んでいる？）場合などがあるでしょう。

参考文献

荒井 裕樹 (2020). 障害者差別を問いなおす 筑摩書房

Bank-Mikkelsen, N. E. (1969). A Metropolitan Area in Denmark: Copenhagen. In B. Kugel & W. Wolfensberger (Eds.), *Changing patterns of residential services for the mentally retarded* (pp. 227–254). President's Committee on Mental Retardation.

Chen, C., Bailey, C., Baikie, G., Dalziel, K., & Hua, X. (2023). Parents of children with disability: Mental health outcomes and utilization of mental health services. *Disability and Health Journal*, 16(4), 101506. <https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2023.101506>

Drotar, D., Baskiewicz, A., Irvin, N., Kennell, J., & Klaus, M. (1975). [The adaptation of parents to the birth of an infant with a congenital malformation: a hypothetical model](#). *Pediatrics*, 56(5), 710–717.

二見 妙子 (2017). インクルーシブ教育の源流：一九七〇年代の豊中市における原学級保障運動 現代書館

平原 春好 (1979). わが国の教育制度史上における「特殊学校」の位置 教育学研究, 46(2), 83–92. <https://doi.org/10.11555/kyoiku1932.46.83>

廣野 俊輔 (2015). 川崎バス闘争の再検討: 障害者が直面した困難とは? 社会福祉学, 55(4), 43–55. https://doi.org/10.24469/jssw.55.4_43

市河 茂樹・山口 直人・高田 栄子・北井 征宏・宮田 理英・是松 聖悟・星野 陸夫・松尾 宗明・平山 雅浩・藤枝 幹也 (2024). 小中学校・特別支援学校教職員を対象とした「教育と医療の連携」に関する web 調査 日本小児科学会雑誌, 128(5), 767–776.

池原 毅和 (2010). 法的能力 松井 亮輔・川島 聡 (編) 概説障害者権利条約 法律文化社

井上 雅彦 (2015). 発達障害と家族支援 精神療法, 41(4), 577–584.

- 井上 雅彦・原口 英之・石坂 美和 (2019). 発達が気になる幼児の親面接：支援者のためのガイドブック 金子書房
- 石井 亮一 (1904). 白痴児, 其研究及教育 丸善
- 石渡 和実 (1997). Q&A 障害者問題の基礎知識 明石書店
- 加藤 康昭 (1986). 滝乃川学園成立史の研究: 初期の学園の性格について 特殊教育研究, 24(3), 50–60. https://doi.org/10.6033/tokkyou.24.50_2
- 河東田 博 (2008). ノーマライゼーション原理とは何か—人権と共生の原理の探究 現代書館
- 川島 聡 (2024). 国連の障害概念：佐藤久生名誉教授の所論をめぐって 障害学会 20 周年記念事業実行委員会（編）障害学の展開：理論・経験・政治 明石書店
- 川島 聡・飯野 由里子・西倉 実季・星加 良司 (2016). 合理的配慮—対話を開く, 対話が拓く— 有斐閣
- 小林 翼・原田 未来 (2013). 障害者の権利に関する条約』にある「合理的配慮」の概念について：とくにその訳の仕方に着目して 山梨障害児教育学研究紀要, 7, 59–69.
- 久米 祐子 (2022). 子どもから障害児を「分けない教育」の戦後史：インクルーシブ教育とは 福岡県人権研究所
- 楠見 友輔 (2024). 倫理に基づく研究を求めて 金子書房 Retrieved March 14, 2025 from <https://www.note.kanekoshobo.co.jp/n/n1930cfd5e26>
- 桑田 左絵・神尾 陽子 (2004). 発達障害児をもつ親の障害受容過程についての文献的研究 九州大学心理学研究, 5, 273–281. <https://doi.org/10.15017/3593>
- 宮本 信也 (2023). 8.8 %の結果が示唆するもの LD 研究, 32(3), 118–127. https://doi.org/10.32198/jald.32.3_118
- 水内 豊和 (2023). 身近なコトから理解するインクルーシブ社会の障害学入門—出雲神話から SDGs まで— ジアース教育新社
- 文部科学省 (2022). 学制百五十年史 ぎょうせい
- 文部省 (1958). 盲聾教育八十年史 文部省
- 中野 善達（編）(1997). 国際連合と障害者問題 エンパワメント研究所

中田 洋二郎 (1995). 親の障害の認識と受容に関する考察-受容の段階説と慢性的悲哀
早稲田心理学年報, 27, 83-92.

Nirje, B. (1969). The Normalization Principle and Its Human Management Implications. In *Changing Patterns in Residential Services for the Mentally Retarded* (p. 5). President's Committee on Mental Retardation.

Nirje, B. (1999). How I came to formulate the Normalization principle. In R. J. Flynn & R. Lemay (Eds.), *A Quarter-Century of Normalization and Social Role Valorization : Evolution and Impact* (pp. 17-50). University of Ottawa Press.

野口 晃菜 (2022). インクルーシブ教育について考えよう 野口 晃菜・喜多 一馬 (編)
差別のない社会をつくるインクルーシブ教育 (pp. 17-34) 学事出版

岡本 稲丸 (1978). 「古川氏盲啞教育法」について—古河太四郎とその教育— ろう教育
科学：聴覚障害児教育とその関連領域, 20(1), 26-38.

大久保 昂 (2024). 特別支援教育巡る文科省通知に撤回勧告 論争の背景 教育新聞 4
月 9 日

小野 次郎 (2012). 教育と医療の連携 上野 一彦・宮本 信也・柘植 雅義 (編) 特別
支援教育の理論と実践 I 概論・アセスメント (第 2 版) (pp. 67-77) 金剛出版

定藤 丈弘・岡本 栄一・北野 誠一 (編) (1993). 自立生活の思想と展望: 福祉のまち
づくりと新しい地域福祉の創造をめざして ミネルヴァ書房

崔 栄繁 (2024, September 2). 成年後見制度の見直しに対する DPI の意見 法制
審議会民法 (成年後見等関係) 部会第 6 回会議資料 Retrieved April 2, 2025 from
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00256.html

佐々木 正美 (2008). 自閉症児のための TEACCH ハンドブック 学研

佐藤 久夫 (2017). 用語の解説 総括所見 パラレルレポート リハビリテーション
研究, 47(2), 42.

佐藤 久夫・小澤 温 (2010). 障害者福祉の世界 第 4 版 有斐閣

Scotch, R. K. (1989). Politics and Policy in the History of the Disability Rights
Movement. *The Milbank Quarterly*, 67, 380-400. <https://doi.org/10.2307/3350150>

菅原 麻衣子 (2022). 特別支援学校生の増加 共生社会の視点で検証を 朝日新聞 4 月
1 日朝刊, 13.

田島 朋子 (2015). 障害受容からの自由 CBR; ja

上田 敏 (1983). リハビリテーションを考える—障害者の全人間的復権 青木書店

- 上田 敏 (2002). 国際障害分類初版 (ICIDH) から国際生活機能分類 (ICF) へ
—改定の経過・趣旨・内容・特徴— 月刊ノーマライゼーション, 22(251),
- 上田 敏 (2005). ICF (国際生活機能分類) の理解と活用 きょうされん
- 梅永 雄二 (2014). 自立をかなえる！ 特別支援教育ライフスキルトレーニングスタートブック 明治図書
- 梅永 雄二 (2017). 発達障害者の就労上の困難性と具体的対策：ASD 者を中心に 日本労働研究雑誌, 59(8), 57-68.
- United Nation. (2003). *Progress of efforts to ensure the full recognition and enjoyment of the human rights of persons with disabilities*. United Nation. Retrieved April 2, 2025, from <https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/general-assembly/progress-of-efforts-to-ensure-the-full-recognition-and-enjoyment-of-the-human-rights-of-persons-with-disabilities-report-of-the-secretary-general-a58181.html>
- World Health Organization. (1996). *Life skills education: planning for research as an integral part of life skills education development, implementation and maintenance*. World Health Organization.
- Yamaoka, Y., Tamiya, N., Moriyama, Y., Garrido, F. A. S., Sumazaki, R., & Noguchi, H. (2015). Mental Health of Parents as Caregivers of Children with Disabilities: Based on Japanese Nationwide Survey. *PLOS ONE*, 10(12), e0145200. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0145200>
- 柳澤 亜希子 (2007). 障害児・者のきょうだいが抱える諸問題と支援のあり方 特殊教育学研究, 45(1), 13-23. <https://doi.org/10.6033/tokkyou.45.13>
- 横塚 晃一 (2007). 母よ！ 殺すな 生活書院